NTS N° 244 - MINSA/DGAIN-2026

"NORMA TÉCNICA DE SALUD UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD CUIDADOS INTENSIVOS"

I. FINALIDAD

Contribuir a mejorar la calidad, seguridad y oportunidad de la atención de salud de los pacientes en estado crítico en los establecimientos de salud a nivel nacional que cuentan con Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos.

II. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Definir el marco normativo para regular la producción de servicios de salud en la Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos: UPSS Cuidados Intensivos, en los establecimientos de salud.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Establecer las disposiciones para la organización, el funcionamiento, la gestión clínica y la atención de salud del paciente en la UPSS Cuidados Intensivos, en los establecimientos de salud que cuentan con ella.
2.2.2 Establecer los requerimientos mínimos de seguridad del paciente, recursos humanos, infraestructura y equipamiento en la UPSS Cuidados Intensivos.
2.2.3 Establecer los criterios para la humanización de la atención del paciente en la UPSS Cuidados Intensivos.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Norma Técnica de Salud es de aplicación obligatoria para las Direcciones y Gerencias Regionales de Salud y las Direcciones de Redes Integradas de Salud de Lima Metropolitana, así como, en los establecimientos de salud que cuentan con la UPSS Cuidados Intensivos, del Ministerio de Salud, de los Gobiernos Regionales, del Seguro Social de Salud - Essalud, de las Sanidades de las Fuerzas Armadas del Perú, de la Sanidad de la Policía Nacional del Perú, así como en todos los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos.

C. ALVARADO CH.

IV. BASE LEGAL

- Ley N° 26454, que declara de orden público e interés nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y suministro de sangre humana.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27604, Ley que modifica la Ley General de Salud N° 26842 respecto de la obligación de los Establecimientos de Salud a dar atención médica en casos de emergencia o partos.
- Ley N° 28189, Ley General de donación y transplante de órganos y/o tejidos humanos.
- Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.
- Ley N° 29664, Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD.
- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedad en estado grave o terminal o sufran accidente grave.

- Ley N° 30421, Ley Marco de Telesalud.
- Ley N° 30846, Ley que crea el Plan Nacional de Cuidados Paliativos para Enfermedades Oncológicas y No Oncológicas.
- Ley N° 30895, Ley que Fortalece la Función Rectora del Ministerio de Salud.
- Ley N° 31756, Ley que promueve la donación de órganos y tejidos humanos para trasplante con fines terapéuticos.
- Decreto Legislativo Nº 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud.
- Decreto Supremo N° 014-2005-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y/o Tejidos Humanos.
- Decreto Supremo N° 024-2005-SA, que aprueba las Identificaciones Estándar de Datos en Salud.
- Decreto Supremo N° 013-2006-SA, que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
- Decreto Supremo N° 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SINAGERD.
- Decreto Supremo N° 005-2012-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Decreto Supremo N° 027-2015-SA, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N° 008-2017-TR, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30012, Ley que concede el derecho de licencia a trabajadores con familiares directos que se encuentran con enfermedades en estado grave o terminal o sufran accidente grave.
- Decreto Supremo Nº 005-2021-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 30421, Ley Marco de Telesalud, y del Decreto Legislativo Nº 1490, Decreto Legislativo que fortalece los alcances de la Telesalud.
- Decreto Supremo N° 060-2024-PCM, que modifica el Reglamento de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres- SINAGERD, aprobado por Decreto Supremo N°048-2011-PCM.
- Resolución Ministerial N° 751-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 018-MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los Establecimientos del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial N° 753-2004/MINSA, que aprueba la NT N° 020-MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Prevención y Control de Infecciones Intrahospitalarias".
- Resolución Ministerial N° 365-2008/MINSA, que aprueba la NTS Nº 067-MINSA/DGSP-V.01: "Norma Técnica de Salud en Telesalud".
- Resolución Ministerial N° 254-2011-MINSA, que aprueba la Guía Técnica para la realización de Procedimientos para el Diagnóstico de Muerte Encefálica.
- Resolución Ministerial N° 372-2011/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica de Procedimientos de Limpieza y Desinfección en los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo".
- Resolución Ministerial N° 540-2011/MINSA, que aprueba la NTS N° 091-MINSA/DIGEMID-V.01: "Norma Técnica de Salud para la Utilización de Medicamentos No Considerados en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales".
- Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, que aprueba la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03: Norma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N° 576-2011/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 183-MINSA/OGEI V.01: "Directiva Administrativa que establece las especificaciones para la estandarización del registro en la historia clínica electrónica".
- Resolución Ministerial N° 853-2012/MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 001 -MINSA/DGSP-V.02: "Directiva Sanitaria para la Evaluación de las Funciones Obstétricas y Neonatales en los Establecimientos de Salud".

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional C. ALVARADO CH.

- Resolución Ministerial N° 099-2014/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N° 197-MINSA/DGSP-V.01, "Directiva Administrativa que establece la Cartera de Servicios de Salud".
- Resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N° 862-2015/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DIGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Tercer Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N° 214-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 139-MINSA/2018/DGAIN: "Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica".
- Resolución Ministerial N° 1295-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 144-MINSA/2018/DIGESA, Norma Técnica de Salud: "Gestión Integral y Manejo de Residuos Sólidos en Establecimientos de Salud, Servicios Médicos de Apoyo y Centros de Investigación".
- Resolución Ministerial N° 030-2020-MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)".
- Resolución Ministerial N° 163-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 92-MINSA/2020/DGAIN: "Directiva Sanitaria de Rondas de Seguridad del Paciente para la gestión del riesgo en la atención de salud".
- Resolución Ministerial N° 249-2020-MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria N° 098-MINSA/2020/DGIESP: "Directiva Sanitaria para el monitoreo y seguimiento de la morbilidad materna extrema en los establecimientos de salud".
- Resolución Ministerial Nº 523-2020-MINSA, que aprueba la NTS Nº 163-MINSA/2020/CDC, "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud".
- Resolución Ministerial N° 653-2021/MINSA, que aprueba la NTS N° 174-MINSA/2021/CDC, "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de la Morbilidad Materna Extrema".
- Resolución Ministerial N° 783-2021-MINSA, que aprueba la NTS N° 176-MINSA/2021/DIGDOT: "Norma Técnica de Salud para la Procura de Órganos y Tejidos Humanos".
- Resolución Ministerial N° 826-2021/MINSA, que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud".
- Resolución Ministerial N° 985-2021/MINSA, que aprueba la "Guía Técnica para el suministro de oxígeno medicinal mediante cánula nasal de alto flujo en el marco de la Emergencia Sanitaria por COVID-19".
- Resolución Ministerial N° 094-2022/MINSA, que aprueba la NTS Nº 181-MINSA/DIGIESP-2022, Norma Técnica de Salud "Manejo de personas afectadas por COVID-19 en áreas de atención crítica de adultos".
- Resolución Ministerial N° 203-2024/MINSA, que aprueba la NTS N° 212-MINSA-DIGEMID-2024, "Norma Técnica de Salud para la preparación de mezclas parenterales para terapia nutricional".
- Resolución Ministerial N° 869-2024-MINSA, que aprueba la modificación de la Norma Técnica de Salud NTS N° 110-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención", aprobada con resolución Ministerial N° 660-2014/MINSA.
- Resolución Ministerial N° 870-2024-MINSA, que aprueba la modificación de la Norma Técnica de Salud NTS N° 119-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del tercer nivel de Atención", aprobada con Resolución Ministerial N° 862-2015/MINSA.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacional
C. ALVARADO CH.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

5.1.1 Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) o Soporte Vital Cardiovascular Avanzado.

El Soporte Vital Cardiovascular Avanzado (ACLS, por sus siglas en inglés) es un conjunto de protocolos clínicos avanzados dirigidos al manejo de emergencias cardiovasculares potencialmente mortales, como el paro cardiorrespiratorio, las arritmias graves, el síndrome coronario agudo y el accidente cerebrovascular. Este soporte integra el reconocimiento temprano, la reanimación cardiopulmonar de alta calidad, el uso de desfibrilación, el manejo avanzado de la vía aérea, la administración de fármacos y el trabajo coordinado en equipo, con el objetivo de restablecer la circulación espontánea y mejorar la supervivencia y el pronóstico neurológico del paciente.

El ACLS está dirigido principalmente a profesionales de la salud capacitados, como médicos, enfermeros y personal de emergencias, y se basa en algoritmos estandarizados desarrollados por organizaciones científicas internacionales.

5.1.2 Basic Life Support (BLS) o soporte vital básico.

El Soporte Vital Básico (BLS, por sus siglas en inglés) es el conjunto de maniobras y procedimientos iniciales que se aplican a una persona que presenta una emergencia vital, como paro cardiorrespiratorio, obstrucción de la vía aérea o respiración ineficaz, con el objetivo de mantener la circulación sanguínea y la oxigenación de los órganos vitales hasta la llegada de atención médica avanzada. Estas maniobras incluyen el reconocimiento precoz de la emergencia, la activación del sistema de emergencias, la reanimación cardiopulmonar (RCP) de alta calidad, el uso del desfibrilador externo automático (DEA) y el manejo básico de la vía aérea, sin el uso de fármacos ni equipos avanzados.

C. ALVARADO CH.

5.1.3 Consentimiento informado.

Es la conformidad expresa del paciente, o de su representante legal cuando el paciente está imposibilitado de hacerlo (por ejemplo: menores de edad, pacientes con discapacidad mental o estado de inconciencia, u otro), con respecto a una atención médica, quirúrgica, o algún otro procedimiento, en forma libre, voluntaria y consciente, después que el médico cirujano o profesional de salud competente que va a realizar el procedimiento le ha informado de la naturaleza de la atención, incluyendo los riesgos reales y potenciales, efectos colaterales y efectos adversos, así como los beneficios, lo cual debe ser registrado y firmado en un documento, por el paciente o su representante legal y el profesional de la atención. No se requiere del consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública.

5.1.4 Continuidad de la atención del paciente en estado crítico.

Es el proceso por el cual el médico cirujano especialista en medicina intensiva brinda atención de salud al paciente en estado crítico desde el momento en que toma contacto con él, y en el sitio y en el contexto en el que se inicia su condición, hasta el momento en que sale de dicho estado. Dicha atención puede ser como médico interconsultante fuera de la UPSS Cuidados Intensivos o tratante, dentro de la UPSS Cuidados Intensivos.

5.1.5 Cuidados Intensivos Extendidos.

Es el cuidado que se brinda, dentro del establecimiento de salud, a fin de asegurar la continuidad de la atención del paciente en estado crítico, o en riesgo de estarlo, ante la existencia de demanda insatisfecha y/o cuando no hay disponibilidad de cama en la UPSS Cuidados Intensivos. La detección, evaluación y tratamiento precoz, se realiza en la UPSS donde se encuentra el paciente, de Hospitalización o Emergencia, hasta que se disponga

de cama en la UPSS Cuidados Intensivos o hasta la estabilización del paciente. El cuidado es realizado por el Equipo de Respuesta Rápida Intensiva.

5.1.6 **Demanda Insatisfecha en Cuidados Intensivos.**
Es la situación en la cual la solicitud de atención de un paciente en estado crítico (demanda) sobrepasa la capacidad de internamiento en la UPSS Cuidados Intensivos (insatisfecha), lo que debería dar lugar a otras modalidades de atención al paciente en estado crítico.

5.1.7 **Equipo de Respuesta Rápida Intensiva ERRI de Cuidados Intensivos Extendidos**
Es el equipo de profesionales de la salud que brindan cuidados intensivos extendidos, en UPSS distintas a la UPSS Cuidados Intensivos, encargado de efectuar la evaluación de pacientes en evolución hacia un estado crítico, o en estado crítico, bajo la modalidad de interconsulta o por búsqueda activa de casos. Estos equipos son conformados por médico cirujano especialista en medicina intensiva y profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos y técnica capacitada en el manejo del paciente crítico del establecimiento de salud, los cuales deben estar programados formalmente en forma exclusiva para esta actividad.
En caso que exista déficit de médicos cirujanos especialistas en Medicina Intensiva, los ERRI son conformados por médicos cirujanos de las especialidades de medicina de emergencias y desastres, medicina interna, cardiología, anestesiología y neumología, capacitados en cuidados intensivos, y por profesionales en enfermería capacitados en cuidados intensivos.

5.1.8 **Enfermedad terminal**
Es aquella situación producto del padecimiento de una enfermedad avanzada, progresiva e incurable en la que no existe posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y con un pronóstico de vida inferior a seis (6) meses.

5.1.9 **Estado Crítico.**
Es la situación en la cual la persona tiene inestabilidad de uno, o más, de sus principales sistemas fisiológicos, con pérdida de su autorregulación, y está en riesgo momentáneo o continuo de perder la vida, o, de sufrir deterioro agudo importante de su calidad de vida, configurando un estado de gravedad persistente que requiere monitorización y soporte avanzado de vida, inmediato y continuo.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

5.1.10 **Gestión Clínica de la UPSS Cuidados Intensivos**
Es la estrategia de mejora que permite sistematizar y ordenar los procesos de atención sanitaria de forma adecuada y eficiente, sustentados en la mejor evidencia científica del momento y con la participación de los profesionales en la gestión para la toma de decisiones en torno al paciente en estado crítico en la UPSS Cuidados Intensivos.

5.1.11 **Historia Clínica.**
Es el documento médico legal, en el que se registran los datos de identificación y los procesos relacionados con la atención del paciente, en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata a la atención de salud que el médico cirujano u otros profesionales de salud brindan al paciente y que son refrendados con la firma manuscrita o digital de dichos profesionales. Las historias clínicas son administradas por cada IPRESS.

5.1.12 **Historia Clínica Electrónica.**
Es la historia clínica registrada en forma unificada, personal, multimedia; refrendada con la firma digital del médico cirujano y otros profesionales de salud, cuyo tratamiento (registro, almacenamiento, actualización, acceso y uso) se realiza en estrictas condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, exactitud, inteligibilidad, conservación y disponibilidad a través de un Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas, de conformidad con las normas aprobadas por el MINSA, como órgano rector.

5.1.13 **Interconsulta.**

Es la actividad asistencial mediante la cual un médico cirujano especialista brinda opinión para definir un diagnóstico, tratamiento o el destino de un paciente (hospitalización, referencia o alta), a solicitud del médico cirujano tratante.

5.1.14 **Junta Médica.**
Es la actividad asistencial realizada por un conjunto de médicos cirujanos especialistas que se constituyen para la toma de decisión conjunta respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un paciente, solicitadas por el médico cirujano tratante o el médico cirujano responsable del establecimiento de salud, teniendo en cuenta las condiciones clínicas del paciente. La decisión conjunta de la Junta Médica es un Acto Médico, por lo tanto, sus conclusiones deben constar en la Historia Clínica y estar debidamente suscritas. El médico convocado a una junta médica no puede rechazar su participación y debe participar de forma obligatoria.

5.1.15 **Mapa Microbiológico Hospitalario.**
Es un informe microbiológico hospitalario a partir de microorganismos aislados de cultivos de muestras clínicas, en el cual se realiza la sistematización de la información microbiológica generada en el establecimiento de salud a partir de los cultivos de los pacientes hospitalizados y ambulatorios para un período de tiempo determinado. Su finalidad es contribuir al uso racional de antimicrobianos para la adecuada prescripción y contención de la resistencia a los antimicrobianos (RAM).

5.1.16 **Mapa Tecnológico.**
Es la estimación epidemiológica, cuantitativa y cualitativa, mediante indicadores, del potencial tecnológico en las unidades de la UPSS Cuidados Intensivos, estableciendo una comparación respecto a la vigencia tecnológica, prospectiva tecnológica y otras innovaciones de referencia del mismo ámbito tecnológico.

5.1.17 **Medicina Intensiva.**
Es la especialidad médica dedicada a la atención de los pacientes críticos con enfermedades o lesiones potencialmente mortales. Estos pacientes requieren monitoreo y terapia constante incluyendo soporte para funciones vitales en unidades de cuidados intensivos (UCI).

C. ALVARADO CH.

5.1.18 **Médico tratante.**
Es el profesional médico que, siendo competente en el manejo del problema de salud del paciente o usuario, conduce el diagnóstico y tratamiento. En la IPRESS que hubiere un grupo de médicos a cargo de la atención en hospitalización, el médico tratante es aquel que atiende por primera vez al paciente a su ingreso en el servicio de hospitalización en tanto permanezca en éste. Cuando el paciente es trasladado a otro servicio o unidad, el médico tratante es aquel que asume su tratamiento médico o quirúrgico. En ambos casos, en ausencia del médico tratante, corresponde al médico Jefe del Servicio o quien haga sus veces, asumir dicha responsabilidad. Lo dispuesto no incluye a los médicos residentes por estar estos profesionales en fase de formación.

5.1.19 **Paciente con enfermedad Terminal**
Es el paciente portador de una enfermedad incurable, de curso progresivo, de mal pronóstico o en situación de muerte inevitable en el que las medidas de soporte vital solo pueden conseguir un breve aplazamiento del momento de su deceso.

5.1.20 **Paciente con Ventilación Mecánica Prolongada (VMP)**
Es el paciente que está en ventilación mecánica por un período de tiempo mayor de 21 días y al menos 6 horas diarias.

5.1.21 **Paciente con Ventilación Mecánica Crónica**
Paciente que está en ventilación mecánica por un período de tiempo mayor de 21 días, las 24 horas del día.

5.1.22 **"Puertas Abiertas" en Cuidados Intensivos**
Es la estrategia de acompañamiento continuo del familiar al paciente de la UPSS Cuidados Intensivos, que contribuye a la humanización del cuidado del paciente, la interacción de la familia con los profesionales que atienden al paciente, a una comunicación efectiva y apoyo por parte de los familiares en las actividades de cuidado. Este acompañamiento debe contar necesariamente con la previa aprobación del médico tratante, registrándola en la historia clínica, siempre que no signifique incremento de riesgo para el paciente y que se observen las prácticas de bioseguridad; caso contrario se revoca dicha aprobación.

5.1.23 **Segunda Opinión**
Es el derecho de los pacientes consagrado en la Ley que establece los Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Salud, que consiste en facilitar que un médico que no pertenezca a la institución pueda tener acceso a la información médica del paciente y emitir una opinión respecto al caso. La finalidad es el beneficio del paciente.

5.1.24 **Teleinterconsulta**
Es la consulta a distancia mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), que realiza un personal de salud a un profesional de la salud para la atención de una persona usuaria, pudiendo ésta estar o no presente; con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos según sea el caso, cumpliendo con las restricciones reguladas a la prescripción de medicamentos y demás disposiciones que determine el Ministerio de Salud. Debe quedar registro de sus conclusiones en la Historia Clínica.

5.1.25 **Telejunta médica**
Es el caso particular de Teleconsulta cuando el servicio de salud no tiene relación unidireccional y/o jerárquica entre el proveedor del servicio y el beneficiario, sino que comparten recursos de información y conocimientos para la toma conjunta de decisiones. Suele utilizarse en el caso de diagnóstico compartido entre médicos cirujanos. Debe quedar registro de sus conclusiones en la Historia Clínica.

C. ALVARADO CH.

5.1.26 **Telemedicina**
Es la provisión de servicios de salud a distancia en los componentes de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, prestados por personal de la salud que utiliza las TIC, con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población.

5.1.27 **Telemonitoreo**
Es la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria, en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en las que se transmite la información clínica de la persona usuaria, y si el caso lo amerita y según criterio médico, los parámetros biomédicos y/o exámenes auxiliares, como medio de control de su situación de salud. Se puede o no incluir la prescripción de medicamentos de acuerdo al criterio médico y según las competencias de otros profesionales de la salud.

5.1.28 **Triaje Terciario**
Es el proceso de triaje de pacientes en estado crítico donde se identifica a los pacientes que precisan de manejo en la UPSS Cuidados Intensivos.

5.1.29 **Unidad Productora de Servicios de Salud (UPSS).**
Es la Unidad Productora de Servicios de Salud organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud en relación directa con el nivel de complejidad del establecimiento de salud

5.1.30 **Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos (UPSS Cuidados Intensivos).**

Es la unidad básica del establecimiento de salud de atención directa, organizada para la atención de salud especializada en medicina intensiva a pacientes en estado crítico, en condición de inestabilidad, de gravedad persistente, con riesgo potencial de muerte y con posibilidades de recuperación parcial o total, que necesitan soporte avanzado de vida y mantenimiento de órganos vitales.

5.1.31 **Unidad de Cuidados Intensivos de Especialidades.**
Es la unidad que brinda una modalidad de atención de salud especializada al paciente cuyo estado crítico está generado por una patología que corresponde ser atendido por una determinada especialidad o subespecialidad médica, o en relación a un determinado campo clínico o grupo etario.

5.1.32 **Unidad de Cuidados Intermedios de Especialidades**
Es la unidad que brinda una modalidad de atención de salud especializada al paciente cuyo estado crítico está generado por una patología que corresponde ser atendido por una determinada especialidad o subespecialidad médica, o en relación a un determinado campo clínico o grupo etario, cuyo estado crítico es de gravedad momentánea o persistente, pero menor que el de la Unidad de Cuidados Intensivos de Especialidades.

5.1.33 **Unidad de Cuidados Intensivos Generales.**
Es la unidad que brinda modalidad de atención de salud especializada al paciente adulto en estado crítico con riesgo inminente de muerte y que requiere atención inmediata, con monitoreo permanente de sus funciones vitales, con apoyo tecnológico y procedimientos médicos especializados.

5.1.34 **Unidad de Cuidados Intermedios Generales.**
Es la unidad que brinda una modalidad de atención de salud especializada al paciente adulto en estado crítico, que necesita monitoreo continuo, apoyo tecnológico y procedimientos médicos especializados, pero cuyo estado crítico es de gravedad momentánea o persistente, menor que el de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales.

C. ALVARADO CH.

5.1.35 **Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos**
Es la unidad que brinda modalidad de atención de salud especializada al paciente pediátrico (hasta 17 años, 11 meses 29 días) en estado crítico, que necesita monitoreo permanente de sus funciones vitales, con apoyo tecnológico y procedimientos médicos especializados, cuya atención corresponde a la especialidad de pediatría intensiva.

5.1.36 **Unidades o Servicios de Soporte para la Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos.**
Son las unidades o servicios especializados que brindan prestaciones de salud a la UPSS Cuidados Intensivos, y que sirven de soporte a la atención del paciente en estado crítico. Son unidades o servicios de soporte: la Unidad de Terapia Respiratoria y Bioingeniería médica o Tecnología Aplicada, y la Unidad de Soporte en Terapia Nutricional Especializada o Unidad de Soporte Nutricional y Metabólica o Servicio de preparación de mezclas parenterales para terapia nutricional.

5.2 El diseño organizacional de los establecimientos de salud, que incluye a las unidades de organización, da soporte a la producción de servicios de salud de atención al paciente en estado crítico, en la UPSS Cuidados Intensivos, para que responda a las necesidades y expectativas de las personas en el territorio, en un marco de gestión por procesos.

5.3 La atención al paciente en estado crítico en la UPSS Cuidados Intensivos, se implementa considerando la racionalización de los procesos asistenciales, administrativos y de gestión en salud, el perfil epidemiológico, el mapa microbiológico, el mapa tecnológico y la optimización de los recursos.

5.4 La UPSS Cuidados Intensivos brinda atención las 24 horas del día durante todo el año.

5.5 El Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, dirige el proceso de toma de decisiones en la atención directa a las necesidades de salud del paciente en estado crítico en toda la UPSS Cuidados Intensivos.

5.6 En la UPSS Cuidados Intensivos se garantiza la atención de salud del paciente en estado crítico con la presencia de médicos cirujanos con RNE en medicina intensiva.

5.7 En la UPSS Cuidados Intensivos se garantiza la atención de salud del paciente en estado crítico, con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud especialistas o capacitados en cuidados intensivos.

5.8 El médico cirujano especialista en medicina intensiva conduce la gestión clínica de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales y de la Unidad de Cuidados Intermedios Generales de la UPSS Cuidados Intensivos.

5.9 El médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica, conduce la gestión clínica de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos y de la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos.

5.10 El médico cirujano especialista en neonatología o el médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología, conduce la gestión clínica de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y de la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales.

5.11 La atención de los procedimientos de apoyo al diagnóstico y al tratamiento requeridos para los pacientes de la UPSS Cuidados Intensivos, así como para los pacientes que se encuentran en Trauma Shock de la UPSS Emergencia, tiene prioridad sobre los requerimientos de otras UPSS, atendiéndoseles de forma ininterrumpida las 24 horas del día.

5.12 Las interconsultas desde la UPSS Cuidados Intensivos tienen prioridad y son atendidas a la brevedad por las otras especialidades médicas y quirúrgicas del establecimiento de salud, durante las 24 horas del día.

C. ALVARADO CH.

5.13 Las intervenciones quirúrgicas del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos tienen prioridad para el ingreso a sala de operaciones de la UPSS Centro Quirúrgico.

5.14 Los Comités Farmacoterapéuticos de los establecimientos de salud solicitan la autorización del uso de medicamentos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales PNUME para los pacientes de la UPSS Cuidados Intensivos, a través del procedimiento que contempla la Resolución Ministerial N° 540-2011/MINSA, que aprueba la "Norma Técnica de Salud para la Utilización de Medicamentos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales PNUME"; o norma que haga sus veces.

5.15 En el establecimiento de salud II-1 que no cuenta con la UPSS Cuidados Intensivos, se puede emplear la Telemedicina, mediante el servicio de teleinterconsulta, como una modalidad inicial, de apoyo especializado para la atención del paciente de riesgo en estado crítico.

5.16 En el establecimiento de salud con UPSS Cuidados Intensivos, el médico cirujano especialista en medicina intensiva puede realizar teleinterconsulta a médicos cirujanos de otras especialidades o de las unidades de cuidados intensivos de especialidades que atienden a pacientes en estado crítico, si lo requieren.

5.17 Los establecimientos de salud desarrollan e implementan sus procesos y procedimientos, teniendo en cuenta su cartera de servicios de salud, la demanda y su capacidad resolutiva, para satisfacer la necesidad de la población de acceder a cuidados intensivos o a cuidados intermedios, como, por ejemplo, ante la alta incidencia de traumatismos, quemaduras, enfermedades neurológicas, entre otras.

5.18 **Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI)**

- Los establecimientos de salud, categoría II-1, que no cuentan con la UPSS Cuidados Intensivos implementan la Unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) en su UPSS Emergencia, a fin de brindar la atención inmediata a un paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo.
- La unidad de Vigilancia Intensiva (UVI) es la unidad de atención al paciente en estado crítico, o en riesgo de estarlo, que requiere estabilización de sus funciones vitales, por lo que se realizan acciones precoces para revertir el estado de gravedad del paciente, estabilizarlo, y/o coordinar, a través del jefe de guardia de la UPSS Emergencia, la referencia, traslado e ingreso oportuno al establecimiento de salud de mayor capacidad resolutiva que cuente con UPSS Cuidados Intensivos.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 En la UPSS Cuidados Intensivos se elaboran, aprueban e implementan los siguientes documentos de Gestión:

- Guías técnicas de los procedimientos médicos más frecuentes en la UPSS Cuidados Intensivos (Anexo N° 1).
- Guías técnicas de intervención de enfermería, según daños más frecuentes en la UPSS Cuidados Intensivos (Anexo N° 2).
- Guías de práctica clínica de los daños más frecuentes en la UPSS Cuidados Intensivos. (Anexo N° 3).
- Plan de auditoria médica de la UPSS Cuidados Intensivos.
- Plan de auditoria en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos.
- Plan de mejora contínua de la calidad en la UPSS Cuidados Intensivos.
- Plan de capacitación anual de la UPSS Cuidados Intensivos que se incluye en el plan de desarrollo del personal del establecimiento de salud.
- Plan anual de mantenimiento preventivo, correctivo y de reposición de equipos de soporte de vida de la UPSS Cuidados Intensivos, que se incluye en el plan multianual de mantenimiento de la infraestructura y del equipamiento del establecimiento de salud.
- Procedimiento de información al paciente, familiar/es y/o al representante.
- Registro de incidencias u ocurrencias en la UPSS Cuidados Intensivos.
- Plan de docencia e investigación, para los establecimientos de salud de Categoría III.
- Plan de Docencia, para los establecimientos de salud de Categoría II, incluidos los establecimientos de salud de Categoría II – E.
- Actividades incluidas en plan operativo institucional.
- Cualquier otro documento, conforme a la normatividad sanitaria vigente.

C. ALVARADO CH.

6.2 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

6.2.1 La UPSS Cuidados Intensivos se organiza para la atención de los pacientes en estado crítico a través de:

a) **UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS GENERALES.**

b) **UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS GENERALES.**

c) **UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ESPECIALIDADES**, que principalmente son:

- Unidad de Cuidados intensivos neonatales.
- Unidad de Cuidados intensivos pediátricos.
- Unidad de Cuidados intensivos maternos.
- Unidad de Cuidados intensivos neurocríticos.

- Unidad de Cuidados intensivos cardiológicos.
- Unidad de Cuidados intensivos de cirugía de tórax y cardiovascular.
- Unidad de Cuidados intensivos oncológicos.
- Unidad de Cuidados intensivos de cirugía de trasplantes.
- Unidad de Cuidados intensivos de quemados, entre otros.

d) **UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS DE ESPECIALIDADES.**

6.2.2 En la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos se garantiza la atención de salud del paciente en estado crítico, con la presencia del médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en medicina intensiva pediátrica; y, de forma complementaria, con médicos cirujanos especialistas en pediatría, o de otras subespecialidades pediátricas, capacitados en cuidados intensivos pediátricos, y médicos cirujanos especialistas en medicina intensiva.

6.2.3 En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se garantiza la atención de salud del neonato en estado crítico, con la presencia del médico cirujano especialista en neonatología o del médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología; y, de forma complementaria, con médicos cirujanos especialistas en pediatría, o de otras subespecialidades pediátricas, capacitados en cuidados intensivos pediátricos, y médicos cirujanos especialistas en medicina intensiva.

6.2.4 En el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos existen las modalidades de atención de salud de Cuidados Intensivos Neurocríticos pediátricos, cuidados intensivos de cirugía de tórax y cardiovascular pediátricos, cuidados intensivos oncológicos pediátricos, cuidados intensivos de cirugía de trasplantes pediátricos y cuidados intensivos de quemados pediátricos.

6.2.5 La Unidad de Cuidados Intensivos Neurocríticos atiende a pacientes en estado crítico con enfermedades neurológicas graves o críticas que hayan sufrido injuria primaria o secundaria cerebral, tanto operados (neuroquirúrgicos) como no operados que precisan control de la presión intracraneana y soporte intensivo.

6.2.6 La UPSS Cuidados Intensivos implementa medidas y cumple actividades de manera permanente, de prevención, vigilancia y control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud.

6.2.7 La UPSS Cuidados Intensivos implementa medidas de aislamiento estricto de los pacientes portadores de infección.

6.2.8 En la UPSS Cuidados Intensivos se implementan las Unidades de Cuidados Intensivos, y las Unidades de Cuidados Intermedios, según la categoría del establecimiento de salud. Ver Tabla N°1.

C. ALVARADO CH.

TABLA N° 1: ORGANIZACIÓN DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS SEGÚN LA CATEGORÍA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

CATEGORÍA DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS			UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS		
	GENERAL	NEONATAL	PEDIÁTRICA Y DE ESPECIALIDADES	GENERAL	NEONATAL	PEDIÁTRICA
II-2	X	X*	-	X	X	
II-E	X**	X**	-	X**	X**	X**

III-1	X	X	X*	X	X	X
III-2	X**	X**	X**	X**	X**	X**
III - E	X**	X**	X**	X**	X**	X**

* Según demanda
** Según requieran por el campo clínico que desarrollan.

6.2.9 El médico cirujano con registro nacional de especialista (RNE) en Medicina Intensiva conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.

6.2.10 Excepcionalmente, en el caso de una declaratoria de estado de Emergencia nacional o de Emergencia sanitaria en el país, o debido a una crisis sanitaria generada por una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud; o en los ámbitos regionales donde existe una brecha en la oferta de médicos cirujanos especialistas en Medicina Intensiva, debidamente sustentada por la Autoridad Institucional de la IPRESS, pasible de verificación, pueden integrarse, mientras dure la medida, al equipo de la UPSS Cuidados Intensivos, médicos cirujanos de las especialidades de Medicina en Emergencias y Desastres, Anestesiología, Medicina interna, Cardiología y Neumología, capacitados y certificados en cuidados intensivos, por la Escuela Nacional de Salud Pública, y/o por otra entidad formadora certificada; estos médicos cirujanos especialistas que se integren al equipo de la UPSS Cuidados Intensivos, estarán bajo la supervisión del médico cirujano especialista en Medicina Intensiva. Esta excepción se aplica únicamente a los establecimientos de salud públicos del ámbito regional.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacional
C. ALVARADO CH.

6.2.11 En el establecimiento de salud de Lima Metropolitana o Región donde no se cuente con el número suficiente de enfermeras(os) especializadas(os) en cuidados intensivos, también se dispone del profesional en enfermería capacitado y certificado en cuidados intensivos, por la Escuela Nacional de Salud Pública y/o por otra entidad formadora certificada. Su labor en la UPSS Cuidados Intensivos está sujeta a lo dispuesto en el numeral 5.6 de la presente norma.

6.2.12 El establecimiento de salud con UPSS Cuidados Intensivos implementa un área para pacientes con Ventilación Mecánica Prolongada, según demanda.

6.2.13 El establecimiento de salud con UPSS Cuidados Intensivos implementa medidas y desarrolla acciones para la atención de los pacientes con necesidad de ventilación mecánica en forma crónica.

6.2.14 CUIDADOS INTENSIVOS EXTENDIDOS

a) Ante una sobredemanda de pacientes que no acceden a la UPSS Cuidados Intensivos, o en situaciones de emergencia sanitaria, o a fin de la continuidad de la atención del paciente en estado crítico, o la detección de pacientes con riesgo de estado crítico, se implementan los Cuidados Intensivos Extendidos dependientes de la UPSS Cuidados Intensivos, quienes acuden a la UPSS donde se encuentra físicamente el paciente en estado crítico o en un área de expansión, interna o externa, del establecimiento de salud.
b) Los Cuidados Intensivos Extendidos tienen como objetivo disminuir la morbimortalidad, en base a la implementación de un sistema de alerta temprana y manejo inicial oportuno.
c) La detección inicial del deterioro de un paciente con sospecha de estado crítico que se encuentra en la UPSS Hospitalización o en la UPSS Emergencia, u otra, la realiza el médico cirujano tratante donde se encuentra el paciente, debiendo solicitar la interconsulta correspondiente al médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos.

d) Los establecimientos de salud que cuentan con la UPSS Cuidados Intensivos y que requieren brindar cuidados intensivos extendidos, cuentan con un equipo de respuesta rápida intensiva (ERRI).
e) El paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo, que no se encuentra en la UPSS Cuidados Intensivos, es atendido por el equipo de respuesta rápida intensiva ERRI de los cuidados intensivos extendidos, los cuales son programados las 24 horas del día para garantizar la continuidad de la atención de salud del paciente.
f) El equipo de respuesta rápida intensiva ERRI realiza la evaluación inicial a los pacientes con deterioro de su condición o sospecha de estado crítico; incluye la evaluación y la respuesta a los códigos rojos o la necesidad de reanimación cardiopulmonar.
g) El médico cirujano especialista en medicina intensiva que tome conocimiento de un paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo, fuera de la UPSS Cuidados Intensivos, debe emitir las recomendaciones de manejo correspondientes al médico cirujano tratante y solicitar que se formalice la interconsulta respectiva para el registro del paciente en la lista de espera de ingreso a la UPSS Cuidados Intensivos.
h) El equipo de respuesta rápida intensiva ERRI, en coordinación y de forma conjunta con el médico cirujano tratante, realiza acciones terapéuticas precoces como: inicio de oxigenoterapia, soporte ventilatorio invasivo, inicio de sistema de alto flujo de oxígeno, colocación de catéter venoso central, inicio de inotrópicos, reanimación cardiopulmonar; abre hojas de monitoreo según los protocolos, guías de práctica clínica y guías técnicas de procedimientos médicos establecidos, para revertir el estado de gravedad del paciente o en caso contrario, para el traslado e ingreso del paciente a la UPSS Cuidados Intensivos.
i) La detección del deterioro del paciente o evolución desfavorable del paciente que ha salido de la UPSS Cuidados Intensivos, la realiza el médico cirujano tratante de la UPSS donde se encuentra el paciente, a través de sistemas de puntuación de alerta temprana y comunica a la UPSS Cuidados Intensivos la necesidad de evaluación del paciente. Además, realiza la interconsulta correspondiente, así como la presentación del caso clínico.
j) El equipo de respuesta rápida intensiva ERRI realiza el seguimiento de los pacientes que han salido de la UPSS Cuidados Intensivos, en coordinación con las unidades de soporte, como la de Terapia Respiratoria y Bioingeniería Médica o Tecnología Aplicada, y la de Terapia Nutricional Especializada o de Soporte Nutricional y Metabólica o Servicio de preparación de mezclas parenterales para terapia nutricional; para disminuir la incidencia de mortalidad oculta o la detección de complicaciones que justifiquen el reingreso del paciente. Dicho seguimiento involucra: lista de verificación para decanulación de cánula de traqueostomía de paciente, prevención de complicaciones en las 48 horas posteriores a la salida del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos; y otras medidas a adoptar, según el tipo y el grupo etario del paciente, y según los protocolos y guías de práctica clínica establecidos para la atención del paciente y la realización de procedimientos médicos.
k) El equipo de respuesta rápida intensiva ERRI cuenta con un sistema de comunicación operativo y permanente.
l) El médico cirujano que conduce la gestión clínica de la UPSS donde se encuentra el paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo, es responsable de la verificación diaria de la operatividad de los equipos de resucitación de la misma. El funcionamiento de todo equipo médico electrónico debe verificarse al iniciar el turno.

6.2.15 UNIDADES O SERVICIOS DE SOPORTE PARA LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

Se consideran, principalmente, las siguientes unidades o servicios de soporte:

- Unidad de soporte en Terapia Respiratoria y Bioingeniería médica o Tecnología Aplicada.
- Unidad de soporte en Terapia Nutricional Especializada o Unidad de Soporte Nutricional y Metabólica o Servicio de preparación de mezclas parenterales para terapia nutricional.

6.2.15.1. UNIDAD DE SOPORTE EN TERAPIA RESPIRATORIA Y BIOINGENIERÍA MÉDICA O TECNOLOGÍA APLICADA

Unidad especializada que brinda apoyo para el soporte respiratorio básico y avanzado al paciente en estado crítico; organiza y gestiona el soporte tecnológico ventilatorio artificial y uso eficiente de los insumos o material respiratorio; invasivo y no invasivo o equipamiento biomédico; da asistencia y monitoreo.

a) Conformado por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario conformado por un profesional médico cirujano especialista en medicina intensiva, un profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, un Tecnólogo Médico en Terapia Física y Rehabilitación, y personal certificado y/o entrenado en el soporte de la ventilación artificial, fisioterapia cardiorrespiratoria, entre otros. Adicionalmente, participa un ingeniero biomédico, o un ingeniero o técnico electrónico.
b) Se implementa en el establecimiento de salud en el que la alta demanda y la vulnerabilidad, a nivel tecnológico, de las unidades de la UPSS Cuidados Intensivos, implican un incremento del riesgo de muerte para el paciente por falla o déficit de soporte biomédico respiratorio.
c) El ambiente de la Unidad de Soporte en Terapia Respiratoria y Bioingeniería médica o Tecnología Aplicada tiene flujos diferenciados de trabajo y medidas de bioseguridad para su adecuado funcionamiento.
d) Vigila diariamente el funcionamiento y mantenimiento adecuado de las máquinas de ventilación indispensables para el sostenimiento de la vida del paciente en estado crítico.
e) Recibe los equipos biomédicos de la UPSS Cuidados Intensivos reportados con fallas y realiza la revisión técnica, a cargo del profesional calificado para ello, con el fin de garantizar el mantenimiento preventivo o correctivo o de calibración, según corresponda, del equipo biomédico, antes de su entrega al área usuaria respectiva. Cuenta con un área de mantenimiento y limpieza de equipos.
f) Las actividades de control de calidad (metrología) están diferenciadas de las actividades de mantenimiento, siendo realizadas independientemente entre sí, y son sostenibles.
g) Los equipos biomédicos son sometidos a evaluación y actualización progresiva y permanente. El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos dispone medidas para su cumplimiento.
h) Esta Unidad puede brindar servicios de salud especializados requeridos por otro establecimiento de salud, o un usuario de salud, en tanto tenga cubierta la demanda de la UPSS Cuidados Intensivos de su establecimiento de salud.



6.2.15.2. UNIDAD DE SOPORTE EN TERAPIA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (UTNE) O UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICA O SERVICIO PARA TERAPIA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA.

Unidad que brinda apoyo para el soporte nutricional o terapia nutricional parenteral, enteral o mixta, al paciente en estado crítico o con enfermedad aguda que no pueda alimentarse de manera convencional; que tiene la responsabilidad de organizar y gestionar la terapia nutricional, así como la prescripción, seguimiento y manejo de la nutrición médica especializada al paciente que lo requiera. En las unidades de cuidados intensivos de neonatología se considera el suministro de Leche Humana Pasteurizada.

a) Conformada por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario de profesionales de la salud capacitados y entrenados en soporte nutricional o terapia nutricional, integrado principalmente por: médico cirujano

especialista en medicina intensiva, y/o médico cirujano pediatra especialista en medicina intensiva pediátrica, y/o médico cirujano especialista en neonatología, médico cirujano especialista en cirugía general, médico cirujano especialista en medicina interna, médico cirujano especialista en gastroenterología, profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, o capacitada en cuidados intensivos; químico farmacéutico especialista y con conocimiento, experiencia y entrenamiento en terapia nutricional parenteral y enteral especializada, y licenciado/a en nutrición con especialidad en nutrición clínica y/o capacitado/a en soporte nutricional.

b) Se implementa en el establecimiento de salud según capacidad resolutiva, perfil epidemiológico y la demanda de esta terapia.
c) Puede formar parte de una red de provisión nutricional artificial parenteral y enteral, y brindar servicios de salud especializados requeridos por otro establecimiento de salud, en tanto tenga cubierta la demanda de su establecimiento de salud, según el marco normativo aplicable.
d) El responsable del establecimiento de salud realiza acciones para la atención de salud de los pacientes con necesidad de nutrición parenteral total en forma crónica, hospitalizados o ambulatorios.

6.3 GESTIÓN CLÍNICA

6.3.1 PLANIFICACIÓN

El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos:

a) Planifica los requerimientos de recursos humanos, infraestructura, equipamiento, mantenimiento, abastecimiento de materiales e insumos, entre otros, de la UPSS Cuidados Intensivos.
b) Garantiza la existencia, disponibilidad, operatividad y buen estado de conservación del equipamiento o instrumental médico, electromédico, eléctrico y mecánico.
c) Conduce la elaboración de los documentos de gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.
d) Monitorea las actividades que se desarrollan en la UPSS Cuidados Intensivos a fin de tomar decisiones en favor del paciente.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

6.3.2 ORGANIZACIÓN

a) La conducción de la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, en forma integral, es realizada por el médico cirujano especialista en medicina intensiva.

b) El médico cirujano especialista en medicina intensiva conduce la gestión clínica de las Unidades de Cuidados Intensivos Generales y de Cuidados Intermedios Generales de la UPSS Cuidados Intensivos.

c) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería en la UPSS Cuidados Intensivos, conduce los procesos de atención de enfermería; tiene responsabilidad sobre el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, y capacitado en cuidados intensivos, sobre la realización de los procedimientos de enfermería, la programación del personal en enfermería, así como sobre los bienes de la UPSS Cuidados Intensivos y de la operatividad de los equipos en dicha UPSS.

d) Disponer la elaboración del plan de capacitación para el personal, así como coordinar y supervisar dicho plan.

e) En la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos se tiene en cuenta la siguiente información (registros):

1. Registro de Indicadores de gestión clínica y de calidad de la UPSS Cuidados Intensivos (Anexos N° 4 y 5).
2. Total de egresos de la UPSS Cuidados Intensivos por día.
3. Total de camas operativas por día y promedio mensual de camas operativas.
4. Perfil epidemiológico del paciente que ingresa a la UPSS Cuidados Intensivos.
5. Perfil de los diagnósticos de egreso de la UPSS Cuidados Intensivos.
6. Registro de eventos adversos en la UPSS Cuidados Intensivos.
7. Registro de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS), y complicaciones.
8. Registro de procedimientos médicos por turno.
9. Registro de ocurrencias e incidentes en las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos.
10. Registro, manual o electrónico, de interconsultas:
    a) Número de interconsultas a las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos por día.
    b) Número de Interconsultas a las unidades de soporte por día.
    c) Número de interconsultas que realiza la UPSS Cuidados Intensivos a otra/s UPSS.
11. Resultados de la Evaluación de la Satisfacción del Usuario en la UPSS Cuidados Intensivos.
12. Registro diario de la información brindada del estado de salud del paciente al familiar y/o al representante.
13. Registro de Enfermería para el seguimiento de prevención y curación de lesiones por presión (LPP), por paciente, desde su ingreso a la UPSS Cuidados Intensivos hasta su salida de la misma.
14. Registro de caídas (para su prevención).
15. Registro de valoración de enfermería con enfoque de riesgos.
16. Registro de las listas de chequeo de los procedimientos médicos invasivos que se realizan a los pacientes de la UPSS Cuidados Intensivos.
17. Registro de las listas de chequeo de ventiladores mecánicos de recepción (al ingresar el paciente) y de salida (cuando el paciente ya no lo requiere).
18. Reporte del consumo de antimicrobianos mediante la metodología internacional reconocida estandarizada basada en el sistema de Dosis Diaria Definida (DDD) que permita hacer comparaciones.

C. ALVARADO CH.

6.3.3 DIRECCIÓN DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos:

a) Conduce los procesos que aseguran el funcionamiento de la UPSS Cuidados Intensivos con eficiencia y calidad.

b) El ejercicio de sus funciones en los aspectos médico - legal y asistencial, es durante las 24 horas del día. Toda delegación de autoridad a un subordinado, en caso de ausencia temporal, debe realizarse por escrito.
c) Propone la directiva interna de buenas prácticas de atención al paciente en estado crítico, a fin de disminuir el riesgo de infecciones asociadas a la atención en salud; la difunde y establece los mecanismos de supervisión de cumplimiento de la normativa en relación a ello.

6.3.4 CONTROL

El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos:

a) Supervisa el cumplimiento de lo establecido en las guías de práctica clínica, según diagnóstico/s del paciente, guías técnicas de procedimientos médicos y otros documentos normativos, por parte del personal a su cargo.
b) Supervisa el cumplimiento de lo establecido en la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, y en su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 027-2015-SA.
c) Selecciona los casos relevantes de Morbilidad Materna Extrema que hayan estado en la UPSS Cuidados Intensivos, y los presenta al Comité de Prevención de Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal del establecimiento de salud, para el análisis, la toma de decisiones y de las medidas correspondientes, de acuerdo a la normatividad vigente.

6.3.4.1 AUDITORÍA DE HISTORIA CLÍNICA.

- El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos aprueba el Plan de Mejora de los procesos de atención y de gestión clínica en la UPSS Cuidados Intensivos, en base a las recomendaciones de las Auditorías médicas, que incluye la auditoria de registro de la historia clínica, auditoría de calidad de atención, auditoría de caso etc. enmarcados en la vigilancia de la seguridad del paciente y con la finalidad de reducir los eventos adversos.
- Los resultados de la evaluación del Plan de Mejora de los procesos de atención y de gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, se presentan a la Oficina de Gestión de la Calidad o la que haga sus veces en el establecimiento de salud.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

6.3.4.2 EVALUACIÓN DE INDICADORES.

El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos evalúa el registro de los indicadores de la UPSS, emite informes trimestrales y anuales de la gestión clínica, que incluyen el análisis de los indicadores y la propuesta de mejora. Estos informes son difundidos a todo el personal de la UPSS Cuidados Intensivos y sirven de insumo para la reformulación de metas y planes.

6.3.4.3 INDICADORES MÁS FRECUENTES A USARSE EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

a) **Indicadores de Gestión Clínica:**

- Promedio mensual de permanencia.
- Porcentaje de ocupación cama/mes.
- Rendimiento cama/mes
- Intervalo de sustitución mensual.
- Tasa de mortalidad bruta y neta.
- Porcentaje de utilización de ventiladores.
- Porcentaje de Neumotórax producidos.
- Promedio de NAS

- Promedio de TISS o NEMS.
- Promedio de APACHE II.
- Promedio de Sequential Organ Failure Assessment (SOFA)[2].
- Promedio mensual de pacientes en estado crítico con indicación de ingreso a la UPSS Cuidados Intensivos, en lista de espera por turno.
- Promedio mensual del tiempo de acceso de pacientes en estado crítico a la UPSS Cuidados Intensivos.
- Promedio mensual del número de pacientes en estado crítico en lista de espera y que no logran ingresar a la UPSS Cuidados Intensivos.
- Scores e indicadores propios de la especialidad a la que se dedican las unidades de cuidados intensivos especializadas.

b) Indicadores de Calidad:

• Indicadores de Estructura

i) Presencia del profesional de enfermería especialista en cuidados intensivos las 24 horas conforme al ratio enfermera por cama.
ii) Porcentaje de equipos biomédicos con:
   - ✓ Mantenimiento preventivo.
   - ✓ Mantenimiento correctivo.
   - ✓ Mantenimiento de calibración.
   - ✓ Equipos No operativos.

• Indicadores de Procesos

iii) Porcentaje de Registro, Notificación y Gestión de Eventos Adversos según clasificación OMS: cuasi-error, incidente y evento adverso.
iv) Porcentaje de adherencia a las guías de práctica clínica y/o protocolos.
v) Implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente: Densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico.
vi) Implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente: Densidad de incidencia de infección asociada a catéter venoso central.
vii) Implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente: Densidad de incidencia asociada a catéter urinario.
viii) Porcentaje de retiro accidental de catéteres vasculares (CV).
ix) Porcentaje de pacientes con lesiones por presión grado 3 o 4 adquiridas en la UPSS Cuidados Intensivos.
x) Incidencia de errores de medicación discriminando por medicamentos de alto riesgo y otros.
xi) Razón de eventos adversos centinela por egresos hospitalarios de la UPSS Cuidados Intensivos.

• Indicadores de Resultados

xii) Razón de mortalidad estandarizada o mortalidad indexada al APACHE II[1].
xiii) Reingresos a la UPSS Cuidados Intensivos.
xiv) Porcentaje de pacientes con lesiones por flebitis.
xv) Mortalidad oculta o mortalidad de los egresos de la UPSS Cuidados Intensivos hasta las 72 horas, indexada al APACHE II.
xvi) Porcentaje de caídas de los pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos.
xvii) Demanda insatisfecha en la UPSS Cuidados Intensivos (Cuidados Intensivos e Intermedios).

C. ALVARADO CH.

[1]Los scores más utilizados en cuidados intensivos son reconocidos principalmente, a través de 4 escalas: APACHE (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), SAPS (Simplified Acute Physiology Score), MPM (Mortality Probability Models) y en pacientes gestantes el SOFA (Sequentia Organ Failure Assessment) de la SOMANZ, (sociedad materna australiana).

xviii) Número de familiares o representante de los pacientes hospitalizados en le UPSS Cuidados Intensivos, que reciben informe médico de acuerdo con lo dispuesto por el establecimiento de salud.

6.4 ATENCIÓN AL PACIENTE DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

6.4.1 EVALUACIÓN PREVIA AL INGRESO A LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

a) El proceso de atención del paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo, comienza en la UPSS donde se encuentra el paciente; el médico cirujano responsable del paciente, genera la interconsulta a la UPSS Cuidados Intensivos.

b) La evaluación al paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo, la realiza el médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos; una vez evaluado el paciente y calificándosele como paciente en estado crítico, se siguen los flujogramas establecidos en el Anexo N° 6: Flujograma de atención del paciente en estado crítico en el establecimiento de salud Categoría II-2 y en el Anexo N° 7: Flujograma de atención del paciente en estado crítico en el establecimiento de salud Categorías III-1, III- 2, III E, a fin de la toma de decisiones en Medicina Intensiva, que implica su derivación a:

1. Unidad de Cuidados Intensivos: Generales o de Especialidades.
2. Unidad de Cuidados Intermedios: Generales o de Especialidades.
3. O su referencia a otro establecimiento de salud con disponibilidad de cama en la UPSS Cuidados Intensivos.

c) Si se considera que el paciente no tiene criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad de cuidados intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos, permanecerá en la misma UPSS con las indicaciones (signos de alarma para seguimiento de la evolución) del médico cirujano especialista en medicina intensiva y bajo el manejo de la UPSS que solicitó la interconsulta.

d) El manejo del paciente en estado crítico, que necesita cama en la UPSS Cuidados Intensivos, cuando no hay disponibilidad en ésta, es asumido por el médico cirujano tratante de la UPSS de donde procede el paciente, junto con el médico cirujano especialista en medicina intensiva programado de turno de trabajo, de preferencia que sea el médico cirujano especialista en medicina intensiva programado en los cuidados intensivos extendidos, si hubiere, hasta la estabilización del paciente o hasta su ingreso a la UPSS Cuidados Intensivos.

e) El paciente en estado crítico que necesita ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos, pero que no hubiere cama disponible en ésta, se le ubica temporalmente, según el siguiente orden de prioridad decreciente:

1. Unidad de Cuidados Intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos.
2. Unidad de Recuperación post anestésica (para los pacientes quirúrgicos en estado crítico) de la UPSS Centro Quirúrgico.
3. UPSS Emergencia, si no hay disponibilidad en las dos anteriores.

f) En el caso de que se necesite el pase del paciente en estado crítico a la Unidad de Recuperación post anestésica, se comunica al médico cirujano con especialidad en Anestesiología que conduce la gestión clínica de la UPSS Centro Quirúrgico o al médico cirujano responsable del turno, o jefe de guardia, en su ausencia.

g) En el caso que se necesite el pase del paciente en estado crítico a la UPSS Emergencia, se comunica al médico cirujano que conduce la gestión clínica de

C. ALVARADO CH.

dicha UPSS, o en su ausencia, al médico cirujano responsable del turno o jefe de guardia.

h) Agotadas las ubicaciones 1, 2 y 3 mencionadas en el literal e) del presente numeral, la unidad de referencias y contrarreferencias del establecimiento de salud o la que haga sus veces, realiza los trámites de referencia del paciente a otro establecimiento de salud con disponibilidad de cama en su UPSS Cuidados Intensivos, según el marco normativo aplicable.

i) La unidad de referencias y contrarreferencias o la que haga sus veces, de los establecimientos de salud, pone en conocimiento de la DIRIS/DIRESA/GERESA sino cuenta con cama/s disponible/s en su UPSS Cuidados Intensivos, según el marco normativo aplicable.

j) Ante la declaratoria de un estado de emergencia nacional o de una emergencia sanitaria en el país, o debido a la crisis sanitaria generada por una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, u otra, los establecimientos de salud públicos, privados y mixtos informan diariamente a la DIRIS/DIRESA/GERESA, si disponen o no de camas en su UPSS Cuidados Intensivos, a fin de que se tomen las medidas correspondientes, según el marco normativo aplicable.

6.4.2 DEL INGRESO DEL PACIENTE A LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

a) Todo ingreso de pacientes a la UPSS Cuidados Intensivos, es indicado por el médico cirujano especialista en medicina intensiva.

b) En caso de no haber familiar o representante, y el estado del paciente precise una intervención o ingreso sin retraso a la UPSS Cuidados Intensivos, se procede de acuerdo con la Ley N° 27604, "Ley que modifica la Ley General de Salud Nº 26842, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos".

C. ALVARADO CH.

c) El paciente que va a ingresar a la UPSS Cuidados Intensivos y su familiar o representante, de ser el caso, debe recibir de parte del médico cirujano especialista en medicina intensiva, información clara y precisa sobre el estado de salud en que se encuentra.

d) A todo paciente, cuando su condición lo permita, o a su familiar, o representante, se le solicita a su ingreso a la UPSS Cuidados intensivos, previa información completa y explicación entendible, que suscriba el consentimiento informado para los procedimientos médicos generales, que se realizan en la UPSS Cuidados Intensivos, así como para la administración de tratamientos, que requeriría. El consentimiento informado debe constar necesariamente por escrito, y forma parte de la historia clínica del paciente, cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa vigente.

e) Para los procedimientos médicos específicos en la UPSS Cuidados Intensivos, el paciente, si es consciente, o su familiar, o su representante legal, subscriben el consentimiento informado por cada uno de los procedimientos, según el marco normativo vigente.

f) El médico cirujano especialista en medicina intensiva identifica las condiciones del riesgo del traslado del paciente en estado crítico, desde la UPSS donde se encuentra el paciente hasta la UPSS Cuidados Intensivos. Para ello evaluará la necesidad de utilizar equipos portátiles durante el traslado.

g) En el caso de gestantes, se toma en consideración los criterios de inclusión de mujeres con morbilidad materna extrema, según la normativa aplicable.

h) El ingreso del paciente en estado crítico a la UPSS Cuidados Intensivos no debe retrasarse, en ningún caso, por documentación incompleta respecto a formatos de las IAFAS u otra razón/es de cobertura del seguro de salud al que estén afiliados; los requisitos faltantes se regularizan posteriormente.

i) Una vez aceptado el ingreso del paciente en estado crítico a la UPSS Cuidados Intensivos, se efectiviza su traslado interno en un tiempo no mayor a una hora desde que se dispone de cama libre en la UPSS Cuidados Intensivos.

j) El cuidado del traslado interno es responsabilidad de la UPSS donde se encuentra el paciente en estado crítico, considerando las indicaciones clínicas dadas por el médico cirujano especialista en medicina intensiva, en su respuesta a la interconsulta, donde se precisa si se requiere que en el traslado interno del paciente se incluya personal de la UPSS Cuidados Intensivos.

k) El profesional en enfermería, de la UPSS donde se encuentra el paciente en estado crítico, coordina las condiciones de su traslado con el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos a la cual ha sido derivado el paciente.

l) El traslado del paciente en estado crítico a la UPSS Cuidados Intensivos, es realizado por el médico cirujano y por el profesional en enfermería de la UPSS de donde procede el paciente, responsables del mismo.

m) El profesional en enfermería de la UPSS de procedencia del paciente, entrega la historia clínica con los exámenes auxiliares realizados, procedimientos médicos y reportes, así como otros documentos del paciente, al profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, o capacitado en cuidados intensivos, de la UPSS Cuidados Intensivos.

n) En el caso del paciente en estado crítico proveniente de la UPSS Centro Quirúrgico, éste es conducido por el médico cirujano especialista en anestesiología y por el médico cirujano especialista en cirugía general o de otra especialidad quirúrgica, a la UPSS Cuidados Intensivos; acompaña siempre el profesional de enfermería.

o) El médico cirujano especialista en cirugía general o de otra especialidad quirúrgica, informa al médico cirujano especialista en medicina intensiva, sobre el reporte operatorio, hallazgos, pronóstico quirúrgico e intercurrencias del paciente proveniente de la UPSS Centro Quirúrgico que va a ingresar a la UPSS Cuidados Intensivos.

p) Al ingreso de todo paciente en estado crítico a la UPSS Cuidados Intensivos, el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la misma, es responsable de solicitar y obtener los datos que permitan comunicarse en forma inmediata con el familiar o representante, comunicándoles el horario en que el médico cirujano especialista en medicina intensiva da información sobre el paciente y sobre la estrategia de "puertas abiertas" de la UPSS Cuidados Intensivos.

q) El médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno o de guardia, realiza la nota de ingreso del paciente que ingresa a la UPSS Cuidados Intensivos. El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos realiza la nota de ingreso o valoración inicial de enfermería.

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional C. ALVARADO CH.

6.4.3 CRITERIOS DE ADMISIÓN A LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

a) Los criterios de admisión a la UPSS Cuidados Intensivos se establecen sobre la base de una combinación de:

- ✓ Diagnóstico que presente el paciente y que compromete seriamente o pone en riesgo su vida.
- ✓ Parámetros clínicos objetivos del paciente al momento de la derivación a la UPSS Cuidados Intensivos, Anexos N° 8 A y 8 B.

- ✓ Necesidades específicas del paciente que solo pueden abordarse en el entorno de la UPSS Cuidados Intensivos, como terapias de soporte vital.
- ✓ Priorización de acuerdo con la condición del paciente (alteración funcional o paramétrica, reserva fisiológica, calidad de vida subjetiva, instrucciones previas determinadas por el paciente).
- ✓ Accesibilidad, oportunidad, disponibilidad de cama, equipamiento e insumos en la UPSS Cuidados Intensivos.
- ✓ Disponibilidad en la Lista de Espera en los casos de sobresaturación de la UPSS Cuidados Intensivos.

b) En todos los casos, las decisiones clínicas del médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos, deben realizarse respetando la dignidad del paciente, los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, los derechos humanos, y en el marco estricto de la bioética.

6.4.4 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE CAMAS.

a) El establecimiento de salud que cuenta con la UPSS Cuidados Intensivos realiza la gestión de camas requerida para su funcionamiento, considerando los estándares establecidos en la Tabla N° 2.

TABLA N° 2: GESTIÓN DE CAMAS EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS *

Categoría del establecimiento de salud	Unidad de Cuidados Intensivos	Unidad de Cuidados Intermedios
II-2	5 a 8% de las camas hospitalarias de adultos del establecimiento de salud	2 camas por cada cama de la unidad cuidados intensivos
	4 a 8% de las camas hospitalarias pediátricas /neonatales	
III-1	8 a 10% de las camas hospitalarias de adultos	3 camas por cada cama de la unidad cuidados intensivos
	4 a 8 % de las camas hospitalarias pediátricas /neonatales	5 a 7 camas de cuidados intermedios neonatales por cada 1000 nacimientos en el área de influencia
III-2	8 a 12% de camas hospitalarias de adultos.	2 camas por cada cama de la unidad cuidados intensivos.
	1 a 1.9 camas de cuidados intensivos neonatales por cada 1.000 nacimientos en el área de influencia	5 a 7 camas de cuidados intermedios neonatales por cada 1000 nacimientos en el área de influencia
II-E	Determinado por la demanda de pacientes en estado crítico en los últimos 12 meses	Determinado por la demanda de pacientes con necesidad de cuidados intermedios en los últimos 12 meses

* Considerar ajuste en función a registros estadísticos de demanda o cálculo adicional por demanda insatisfecha si corresponde.

C. ALVARADO CH.

b) El número de camas de la unidad de cuidados intensivos neonatales es determinado de acuerdo al número de nacimientos y se incrementa en razón al número de neonatos referidos.

c) Para la asignación de camas durante la admisión y el triaje terciario se sugieren las siguientes herramientas:

- Parámetros clínicos de potencial recuperabilidad en pacientes en estado crítico adultos (Anexo N° 8 A) y Criterios Pediátricos de Admisión a la UPSS Cuidados Intensivos (Anexo N° 8B); y, Prioridades de admisión a la UPSS Cuidados Intensivos, (Anexo N°9).
- Herramientas para la Admisión y Asignación de Recursos en la UPSS Cuidados Intensivos (Anexo N° 10).

d) En el caso de Cuidados Intensivos Extendidos, el número de camas asumidas por el médico cirujano especialista en medicina intensiva, para el manejo conjunto con el médico cirujano tratante de la UPSS donde se encuentra el paciente en estado crítico, dependerá del número de recursos humanos y de la logística disponible en la UPSS Cuidados Intensivos, respetando las directivas, procesos y procedimientos establecidos por cada establecimiento de salud en condiciones de sobredemanda y sobresaturación de pacientes en estado crítico.

e) En condiciones de sobredemanda en la UPSS Cuidados Intensivos, causada por emergencia masiva o desastre, o crisis sanitaria y tomando en cuenta los principios de integridad y ética, así como de respeto al paciente, pueden considerarse las recomendaciones generales adicionales a los criterios previamente descritos según el Anexo N°11 (*"Recomendaciones generales en condiciones de sobredemanda en la UPSS Cuidados Intensivos causada por emergencia masiva o desastre")*.

C. ALVARADO CH.

6.4.5 ATENCIÓN MÉDICA EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

a) El médico cirujano especialista en medicina intensiva evalúa al paciente, elabora el plan de trabajo, considerando los procedimientos médicos a realizar y manteniendo el monitoreo y la evaluación continua del paciente en estado crítico durante las 24 horas de cada día en que se encuentre en la UPSS Cuidados Intensivos.

b) El médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos, realiza procedimientos médicos y registra en la Historia Clínica del paciente, los procedimientos médicos realizados, indicando la fecha, la hora, con su nombre, firma y sello. Debe quedar registrado en la HC los criterios que presenta el paciente para hacerlo candidato a la intervención, más aún en el caso de Emergencia.

c) En la Historia Clínica consta en forma visible y de rápida ubicación, los datos del familiar responsable, o de su representante legal, del paciente en estado crítico: nombre, dirección y teléfonos, para la comunicación directa con ellos.

d) El médico cirujano especialista en medicina intensiva supervisa el cumplimiento de las indicaciones médicas efectuadas al personal de salud de la UPSS Cuidados Intensivos respecto a los cuidados, manejo y tratamiento del paciente en estado crítico.

e) El médico cirujano especialista en medicina intensiva cumple con lo establecido en las guías de práctica clínica, protocolos y manuales de procedimientos para la atención del paciente en estado crítico.

f) Los procedimientos médicos efectuados en la UPSS Cuidados Intensivos cumplen las disposiciones vigentes sobre el consentimiento informado y se realizan en base a las Guías Técnicas.

g) El médico cirujano especialista en medicina intensiva completa en cada turno: los registros establecidos para la UPSS Cuidados Intensivos, los datos de la historia clínica, la toma de decisiones asumidas y los resultados del plan de trabajo efectuado, en forma manual o electrónica, según se disponga, de cada uno de los pacientes en la UPSS Cuidados Intensivos.

h) Al final de cada turno, el médico cirujano especialista en medicina intensiva saliente entrega el turno al médico cirujano especialista en medicina intensiva entrante, e informa acerca del estado clínico del paciente, así como de las actividades y los procedimientos médicos realizados, los mismos que se encuentran documentados en el Registro Diario de Actividades y Procedimientos Médicos de la UPSS Cuidados Intensivos (Anexo N° 12), y su Instructivo contenido en el Anexo N° 13; además informa de los procedimientos médicos pendientes de realizar, y determina, con el médico cirujano especialista en medicina intensiva entrante, el plan de trabajo a seguir para cada paciente que permanece en la UPSS Cuidados Intensivos.

i) Al final de cada turno el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos saliente, entrega el turno al profesional en enfermería especialista en cuidado intensivos entrante, mediante un reporte de la información y de los datos referentes al paciente, los pendientes del turno a continuar y a cumplir, así como de los cuidados y el tratamiento indicado por el médico cirujano especialista en medicina intensiva.

C. ALVARADO CH.

6.4.6 INTERCONSULTAS

a) Toda interconsulta que se solicita desde la UPSS Cuidados Intensivos, a otra/s UPSS, es firmada por el médico cirujano especialista en medicina intensiva, o por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, especificando la fecha, hora y UPSS de destino. La interconsulta es contestada en un plazo máximo de 2 horas, contadas a partir de la recepción de la misma en la UPSS consultada.

b) La respuesta a las interconsultas para mujeres con Morbilidad Materna Extrema debe darse en el espacio de tiempo de una hora ("hora de oro").

c) Las interconsultas de otras UPSS solicitadas a la UPSS Cuidados Intensivos, son atendidas por el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno o por el médico cirujano programado en cuidados intensivos extendidos, cuando exista, según la prioridad y complejidad del estado del paciente; quien/es realiza/n indicaciones y coloca su nombre con firma y sello, así como la fecha y hora de la respuesta.

d) En caso de existir los Cuidados Intensivos Extendidos, éstos son la primera instancia de resolución de las interconsultas por medio de los ERRI, asimismo, los ERRI evalúan a los pacientes en estado crítico y/o realizan procedimientos médicos de medicina intensiva fuera de la UPSS Cuidados Intensivos. La interconsulta es contestada en un plazo máximo de 1 hora, si existen los Cuidados Intensivos Extendidos, contada a partir de la recepción de la misma en la UPSS Cuidados Intensivos.

e) Toda interconsulta solicitada o respondida se registra en la Historia Clínica del paciente; y adicionalmente es registrada en una base de datos de interconsultas de la UPSS Cuidados Intensivos, consignando el nombre del médico cirujano

interconsultante y del interconsultor. Si se dispone de registro electrónico debe llenarse en tiempo real para el análisis correspondiente.

f) En el caso de los establecimientos de salud con pacientes en riesgo de estar en estado crítico, y que no cuentan con médico cirujano especialista en medicina intensiva y que tienen la necesidad de interconsulta a distancia, ésta se efectúa mediante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) implementadas en el establecimiento de salud.

6.4.7 JUNTA MÉDICA

a) El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos o el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno o de guardia, según corresponda, es responsable de convocar a médicos cirujanos de otras especialidades en caso se requiera opinión conjunta para la toma de decisión en relación con el diagnóstico y tratamiento del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos.

b) En la Historia Clínica se registran las conclusiones, fecha, hora y participantes de la Junta Médica, así como las firmas correspondientes. Modelo de Formato de Junta Médica de la UPSS Cuidados Intensivos en el Anexo N° 14.

c) La participación en la Junta Médica es de carácter obligatorio para los profesionales de las especialidades convocadas.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

6.4.8 EXÁMENES DE APOYO AL DIAGNÓSTICO

a) Los exámenes de apoyo al diagnóstico que son solicitados por el médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos, son tramitados de forma inmediata registrándose la fecha, hora, tipo de examen y el nombre de la persona del servicio de apoyo al diagnóstico y al tratamiento que recepciona la solicitud, y son realizados en la unidad al pie de cama del paciente en la UPSS Cuidados Intensivos.

b) De ser necesario trasladar al paciente al servicio de apoyo al diagnóstico y al tratamiento del establecimiento de salud, el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos realiza la coordinación, previa para la inmediata atención.

c) De ser necesario el traslado del paciente al servicio de apoyo al diagnóstico y al tratamiento, es de responsabilidad del profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos informar al médico cirujano especialista en medicina intensiva si observa inestabilidad en el paciente.

d) Durante la realización de los exámenes, sea en la unidad al pie de cama del paciente o si éste hubiera sido trasladado, el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos permanece con el paciente durante todo el tiempo de la realización de ellos, evaluando permanentemente las funciones vitales del paciente.

e) El personal técnico (a) en enfermería es responsable del pronto recojo de los resultados en coordinación con el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, de no existir medios electrónicos.

6.4.9 INFORMACIÓN AL PACIENTE Y/O A SU FAMILIAR O REPRESENTANTE EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

a) Todo paciente que va a ser ingresado en la UPSS Cuidados Intensivos, cuando su condición lo permita, o a su familiar, o representante legal, recibe al ingreso a la UPSS Cuidados Intensivos, información clara, precisa y suficiente sobre las características de la atención de salud en dicha UPSS, y acerca de la estrategia de "puertas abiertas" en cuidados intensivos.

b) Todo paciente, cuando su condición lo permita, y su familiar, o representante legal, es informado adecuada y oportunamente de los derechos que tiene como usuario de los servicios de salud y de cómo ejercerlos, tomando en consideración su idioma, cultura y circunstancias particulares.

c) La información sobre la condición del paciente, sea al mismo paciente, si su condición lo permite, o a su familiar, o representante legal, es completa, oportuna y continua, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias sobre las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se le prescriban y administren; y sobre la evolución clínica, pronóstico y el plan de trabajo. El médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o de guardia, se asegura que el paciente y el familiar, o representante, comprenda la información que se le proporciona. La información tiene que ser sincera y veraz, preguntando al final si existiera alguna duda o precisión. Se debe emplear un lenguaje sencillo, claro y comprensible, adaptado a la persona a la que se le está transmitiendo la información, y empatía.

d) El médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o de guardia, informa, obligatoria y diariamente, al familiar, y/o representante legal, del paciente, sobre el estado del paciente, en el horario previamente establecido por la UPSS Cuidados Intensivos, y, se toma un tiempo adecuado para la comprensión del familiar, y/o representante, de cada paciente. Adicionalmente, y fuera del horario establecido, si la salud del paciente se deteriora, el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, informa al familiar, y/o representante legal, del paciente, de ello. La información al familiar, y/o representante, es un derecho y un acto prioritario, especialmente cuando el deterioro del estado del paciente hace prever un desenlace fatal.

C. ALVARADO CH.

e) Diariamente se registra en la historia clínica de cada paciente, el informe médico que ha sido dado al familiar, y/o al representante, el cual consigna fecha, hora, nombre, DNI y firma del familiar, y/o representante, que ha sido informado.

f) De no acudir presencialmente el familiar o el representante a la UPSS Cuidados Intensivos, obligatoriamente se le llama por teléfono y se insiste hasta lograr la comunicación correspondiente. El médico cirujano registra el acto realizado en la Historia Clínica del paciente, consignando la fecha, hora, nombre y el parentesco del familiar o representante legal informado.

g) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos informa al familiar y/o al representante legal del paciente, sobre los cuidados especializados de enfermería realizados en su turno.

6.4.10 VISITA DEL FAMILIAR Y/O REPRESENTANTE AL PACIENTE

a) El profesional en enfermería especialista en cuidado intensivos informa y entrega al familiar o al representante legal del paciente, una cartilla informativa o información impresa, que consigna el horario de los informes médicos, de las visitas al paciente, así como acerca del acompañamiento al paciente por sus familiares. Las excepciones al acompañamiento al paciente, así como las visitas, tenderán a ser mínimas.

b) De usarse los pases de visita en el establecimiento de salud donde se encuentra el paciente, éstos son autorizados por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, o médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o de guardia, en ausencia del primero, siendo entregados por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, a los familiares, o representante, del paciente.

c) El profesional en enfermería especialista en cuidado intensivos, al momento del ingreso de la visita del paciente, les informa sobre el procedimiento para el lavado de manos, colocación del mandilón u otro aditamento o equipo de protección personal, supervisando dichas acciones y asegurándose de su correcto uso.

d) El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, o el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o de guardia, sino estuviere el primero, da indicaciones para extender el periodo de visita y/o el acompañamiento del familiar del paciente al máximo posible, considerando principalmente, el criterio de humanización de la atención, así como los criterios de gravedad y bioseguridad.

e) Las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, Cuidados Intensivos Pediátricos y Unidades de Cuidados Intensivos de Especialidades Pediátricas, son de "puertas abiertas", liberalizando el horario de visitas para que los padres puedan permanecer acompañado a sus hijos, basados en el concepto de "Cuidados Centrados en la Familia".

f) Las Unidades de Cuidados Intensivos Generales y de Cuidados Intensivos de Especialidades de adultos, se orientan a ser de "puertas abiertas".

C. ALVARADO CH.

6.4.11 EGRESO DEL PACIENTE DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

a) El médico cirujano especialista en medicina intensiva indica la salida del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos de acuerdo a los siguientes criterios:

- Cuando el estado fisiológico del paciente se ha estabilizado.
- Cuando ya no es necesaria la monitorización ni el tratamiento intensivo.

b) El paciente y su familiar, y/o representante, son informados previamente sobre la salida del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos y su pase a otra UPSS del establecimiento de salud.

c) El médico cirujano especialista en medicina intensiva realiza la nota de egreso del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en el Anexo N° 15, y consigna en la Historia Clínica del paciente el Plan de Trabajo, acciones pendientes y recomendaciones, de manera que se garantiza la transferencia de información y la continuidad de la atención de salud en la UPSS adónde pasa el paciente.

d) El médico cirujano especialista en medicina intensiva determina las condiciones del traslado del paciente desde la UPSS Cuidados Intensivos hasta la UPSS de destino.

e) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, de la UPSS Cuidados Intensivos, prepara al paciente para su salida de ésta y para su traslado a la UPSS de destino cumpliendo con las indicaciones médicas específicas al caso.

f) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, de la UPSS Cuidados Intensivos, coordina la disponibilidad de cama en la UPSS de destino.

g) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, de la UPSS Cuidados Intensivos, coordina previamente con el profesional en enfermería de la UPSS destino, las condiciones para el adecuado traslado del paciente.

h) El traslado del paciente es realizado por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos y el personal técnico en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos.

i) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos, reporta al profesional en enfermería de la UPSS de destino, las condiciones clínicas del paciente, entrega la historia clínica, placas radiográficas, otros aditamentos del paciente, así como la documentación respectiva y los bienes personales del paciente que estuvieron bajo su responsabilidad, y se consigna la firma del profesional en enfermería de la UPSS de destino que recibe todo ello.

j) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos, informa al profesional en enfermería de la UPSS de destino, sobre los cuidados especiales de enfermería y procedimientos de enfermería del paciente.

k) En el control de enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos, consta el registro de: la UPSS de destino del paciente, la fecha, hora y nombre del profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos a cargo del traslado interno del paciente y el nombre del profesional en enfermería de la UPSS de destino que recibe al paciente.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

l) Excepcionalmente, la salida de un paciente de la UPSS Cuidados Intensivos es a su domicilio, dándosele de Alta del establecimiento de salud, lo cual depende de las condiciones del paciente y de la indicación del médico cirujano especialista en medicina intensiva; se informa al médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y al responsable del establecimiento de salud.

m) El responsable del establecimiento de salud realiza un programa de seguimiento personalizado y multidisciplinario a los pacientes que han estado en la UPSS Cuidados Intensivos y que salieron de Alta del establecimiento de salud, pero que presentan un riesgo incrementado de reinternamiento en el establecimiento de salud.

6.4.12 FALLECIMIENTO.

a) Si un paciente en estado crítico fallece durante el traslado interno a la UPSS Cuidados Intensivos, la UPSS de la cual procede es responsable de emitir el certificado de defunción.

b) Si el fallecimiento del paciente se da en la UPSS Cuidados Intensivos el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o de guardia, constata y certifica el mismo y emite el certificado de defunción correspondiente, según normativa vigente.

c) El médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno es responsable de comunicar inmediatamente al familiar/es, y/o al representante legal del paciente, acerca de su fallecimiento; así como de realizar la epicrisis.

d) El médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, personalmente, en forma veraz, completa, oportuna, con amabilidad y respeto, informa sobre el fallecimiento del paciente al familiar, o representante, y hace uso de las técnicas de comunicación en situaciones críticas con empatía.

e) Una vez constatado el fallecimiento del paciente, el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos, realiza el retiro de los equipos biomédicos invasivos y otros, de acuerdo a lo señalado por el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o de guardia.

f) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, de turno, de la UPSS Cuidados Intensivos, junto con el personal técnico en enfermería, preparan el cadáver y siguen las normas de manejo de cadáveres en situaciones ordinarias o de emergencia, según corresponda.

g) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, de turno, de la UPSS Cuidados Intensivos, verifica y supervisa la limpieza e higiene de la cama del paciente fallecido, de su unidad y del ambiente, lo que es realizado por el personal técnico en enfermería y por el personal de limpieza, según las normas vigentes de limpieza y desinfección.

h) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos de la UPSS Cuidados Intensivos, orienta al familiar, y/o al representante, del paciente fallecido sobre los procesos a seguir para la recepción y retiro del cadáver.

i) En el caso de que se requiera necropsia clínica, se solicita autorización al familiar, o al representante, del paciente fallecido; su autorización o su negativa son registradas en la Historia Clínica, procediéndose de acuerdo a la legislación vigente.

j) En los casos de necropsia de ley, el cadáver es derivado a las divisiones que cuenten con el servicio Tanatológico Forense del Ministerio Público de acuerdo con la normatividad vigente, y en esa dependencia se expide el Certificado de Defunción.

6.4.13 PRINCIPALES PRESTACIONES DE SALUD Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

Las principales prestaciones de salud, de la cartera de servicios de salud del establecimiento de salud, y los principales procedimientos médicos que se llevan a cabo en la UPSS Cuidados Intensivos se encuentran en los Anexos N° 16 y 17.

6.5 SEGURIDAD EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

6.5.1 SEGURIDAD DEL PACIENTE

Para la seguridad del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos se dispone lo siguiente:

a) Prevención de lesiones por presión.

b) Prevención de complicaciones por restricciones rutinarias de la movilidad.

c) Implementación de prácticas de administración segura de medicamentos.

d) Identificación inequívoca del paciente, que no incluya el número de cama como identificador.

e) Prevención de caídas del paciente.

f) Rondas de seguridad del paciente.

g) Lavado e higiene de manos según corresponda.

h) En la Historia Clínica debe quedar registro de los criterios para implementar un procedimiento invasivo.

i) Procedimiento estandarizado para la entrega de información al paciente, al familiar, y/o representante.

j) Evaluación continua de riesgos, que incluye el análisis de eventos adversos, como parte de la gestión de riesgos dentro de la UPSS Cuidados Intensivos.

k) Implementación de Listas de verificación para los procesos y procedimientos médicos de riesgo, así como para evaluar el cumplimiento del tratamiento de acuerdo con las Guías de Práctica Clínica y Guías Técnicas de Procedimientos Médicos implementadas en la UPSS Cuidados Intensivos.

l) Información educativa y comunicacional al paciente recuperado de la UPSS Cuidados Intensivos y a su familiar o representante, entre otras medidas de seguridad.

6.5.2 BIOSEGURIDAD

Para el Paciente

a) Vigilancia, prevención y control de las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud - IAAS, en la UPSS Cuidados Intensivos.

b) Supervisión, monitoreo y evaluación periódica, en las diferentes unidades de la UPSS Cuidados Intensivos, en cuanto al cumplimiento de las normas de prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud.

c) El acceso del personal de otras UPSS, que no contribuyen al cuidado o atención de salud del paciente que se encuentra en la UPSS Cuidados Intensivos, debe ser restringido.

Del Trabajador

a) Plan de capacitación sobre: Bioseguridad en la UPSS Cuidados Intensivos, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, manejo de residuos sólidos, entre otros, para el personal que ingresa a trabajar en la UPSS Cuidados Intensivos, incluido el profesional de Residentado o de segunda especialización.

b) La seguridad del trabajador está sujeta a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y/o al marco normativo aplicable.

Del Ambiente

a) En la UPSS Cuidados Intensivos se utiliza uno de los siguientes sistemas de desinfección de los ambientes, con y sin presión negativa, que son:

- Sistema ultravioleta.
- Sistema de Ozono.
- Sistema mixto de Ultravioleta – Ozono.
- Sistema de Peróxido de hidrogeno.

b) La limpieza y desinfección de toda la UPSS Cuidados Intensivos se realiza cada 12 horas. Adicionalmente, la limpieza de los equipos y del material textil de la UPSS Cuidados Intensivos, se realiza según las normas y según los manuales de uso del fabricante.

c) El personal de limpieza permanece en la UPSS Cuidados Intensivos para la limpieza de los ambientes a demanda (salidas, ingresos y contingencias).

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

d) La limpieza de la "unidad del paciente" está a cargo del personal técnico (a) en enfermería, según el marco normativo aplicable.

e) El Plan de manejo de residuos sólidos de la UPSS Cuidados Intensivos guarda coherencia con el Plan de Manejo de Residuos Sólidos del establecimiento de salud y éste incluye al primero.

6.6 RECURSOS HUMANOS

a) La UPSS Cuidados Intensivos cuenta con un equipo interdisciplinario de salud conformado por médicos cirujanos especialistas en medicina intensiva, profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos y personal técnico (a) en enfermería con capacitación en cuidados intensivos. Complementariamente al equipo interdisciplinario, brindan soporte: el Tecnólogo Médico en terapia física y rehabilitación, el químico farmacéutico, los licenciados en nutrición capacitados en soporte nutricional artificial, los licenciados en psicología y el personal certificado y/o entrenado en soporte de la ventilación artificial, fisioterapia cardiorrespiratoria, entre otros.

b) Las unidades de cuidados intensivos de especialidades se conforman con médicos cirujanos de la especialidad y/o subespecialidades relacionadas al campo clínico y/o grupo etario al que se dedican, capacitados en cuidados intensivos; adicionalmente lo conforma el médico cirujano especialista en medicina intensiva.

c) La Autoridad Regional de Salud y la Autoridad de Salud de Lima Metropolitana correspondiente, determina el requerimiento de recursos humanos necesarios para la atención de salud en la UPSS Cuidados Intensivos, así como de camas, de cada establecimiento de salud de la jurisdicción bajo su responsabilidad, considerando la complejidad de estas atenciones, el perfil epidemiológico de su población, la frecuencia de pacientes en estado crítico, la distribución geográfica, el número y edades de su población, la infraestructura y el equipamiento que disponen, y las posibles contingencias naturales o biológicas.

d) La Autoridad Nacional de Salud verifica el cumplimiento del literal c).

e) La necesidad de recursos humanos para el funcionamiento de la UPSS Cuidados Intensivos se establece en función a la ratio del número de pacientes hospitalizados/profesional de salud, contemplados en la presente norma (Tabla N°3).

C. ALVARADO CH.

Tabla N° 3: Relación de número de pacientes por recurso humano en la UPSS Cuidados Intensivos

Personal de Salud	UPSS Cuidados Intensivos		
	Unidad de Cuidados Intensivos	Unidad de Cuidados Intermedios	Cuidados Intensivos Extendidos
Médico especialista en medicina intensiva (medicina intensiva adultos, pediátrica y neonatal)	• Un (01) médico especialista en medicina intensiva por cada 6 pacientes.	• Un (01) médico especialista en medicina intensiva por cada 8 pacientes	• Un (01) médico especialista en medicina intensiva para seguimiento de 8 pacientes hospitalizados fuera de la UPSS Cuidados Intensivos y/o con demanda de más de 8 interconsultas para la UPSS Cuidados Intensivos por día. *
Profesional de enfermería especialista en cuidados intensivos	**Escala de NAS (Nursing Activities Score)** [2] • Un (01) profesional de enfermería especialista en cuidados intensivos por 1 paciente si la escala de NAS es mayor al 50% empleado en el paciente en estado crítico. • En Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales la relación es un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos neonatales por cada 2 pacientes (*) **<u>Escalas alternativas:</u>** **NEMS (nine equivalents of Nursing Manpower use score)**[3] • Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por un 1 paciente Si la escala de NEMS, es mayor de 34 o si cada TISS* 28 es mayor de 39.	• Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 3 pacientes, si estos no dependen de soporte ventilatorio o es de baja complejidad. • Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 2 pacientes en estado crítico, si estos dependen de soporte ventilatorio. • En Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales la relación es un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 4-5 neonatos (*)	• Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 4 pacientes hospitalizados fuera de la de la UPSS Cuidados Intensivos

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

[2] Sistema de puntuación, reconocido como descriptor del trabajo de Enfermería en UPSS Cuidados Intensivos y como predictor de la gravedad del paciente.
[3] Sistema de evaluación de la gravedad en la UPSS de Cuidados Intensivos, cuanto más se aparta de los valores establecidos, más grave se encuentra el paciente.

Personal de Salud	UPSS Cuidados Intensivos		
	Unidad de Cuidados Intensivos	Unidad de Cuidados Intermedios	Cuidados Intensivos Extendidos
	TISS-28 (Simplified Therapeutic Intervention Score System) [4] • Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 2 pacientes si cada TISS*28, (Simplified Therapeutic Intervention Score System), es menor de 39.		
Técnica(o) en enfermería.	• Un (01) técnica (o) en enfermería por cada 3 pacientes adultos • Un (01) técnica (o) por cada 6 pacientes neonatos.	• Un (01) técnica (o) por cada 4 pacientes sin soporte ventilatorio. • Un (01) técnica (o) por cada 3 pacientes con soporte ventilatorio. • Un (01) técnica (o) por cada 6 pacientes neonatos.	
Personal de Limpieza	La distribución del personal de limpieza se realiza por cada una de las unidades o áreas de la UPSS Cuidados Intensivos de acuerdo a necesidad. (**)		

(*) En el caso de cuidados intensivos e intermedios neonatales la relación de número de paciente por profesional en enfermería varía y en casos de alta tecnología y cuidados de alta dependencia.
(**) Se garantiza que mínimamente la limpieza y desinfección de la UPSS Cuidados Intensivos se realice cada 12 horas y el personal de limpieza permanece en la unidad, o ambiente, dentro de la UPSS Cuidados Intensivos para la limpieza de los ambientes: a demanda, en egresos de la UPSS, ingresos y contingencias.

f) La capacitación en cuidados intensivos del médico cirujano de las especialidades de medicina en Emergencias y Desastres, Anestesiología, Medicina interna, Cardiología y Neumología, y del profesional en enfermería, debe ser certificada por la Escuela Nacional de Salud Pública, y/o por otra entidad formadora autorizada.
g) La capacitación en cuidados intensivos pediátricos de los médicos especialistas en medicina intensiva, médicos especialistas en pediatría o de otras subespecialidades pediátricas, y del profesional en enfermería, debe estar certificada por la Escuela Nacional de Salud Pública, y/o por otra entidad formadora autorizada.
h) La capacitación y posterior actualización de los profesionales de la salud en la UPSS UCI en Basic Life Support (BLS) y Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS), debe estar certificada, según corresponda.
i) Para el soporte de los procesos de atención de salud y de gestión clínica en la UPSS Cuidados Intensivos, se dispone de personal de apoyo como secretaria y/o técnico administrativo.
j) El profesional de la salud de la UPSS Cuidados Intensivos no puede ser desplazado a otra UPSS, excepto por necesidad extrema del establecimiento de salud, como la sobredemanda de la atención de las víctimas en caso de emergencia o desastres, siempre

[4] Sistema simplificado de puntuación para medir la carga de trabajo de enfermería en las Cuidados Intensivos. Se basa en un listado de 28 intervenciones terapéuticas, a las que se asigna un puntaje según su complejidad e intensidad.

y cuando no afecte la atención de los pacientes de la UPSS Cuidados Intensivos. El responsable del establecimiento de salud decide este desplazamiento.

k) El profesional de la salud de la UPSS Cuidados Intensivos asiste y participa en las reuniones convocadas por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de esta UPSS, del análisis de los indicadores, de la evaluación de la satisfacción del usuario externo y en el desarrollo de estrategias para la investigación y otras actividades vinculadas a la UPSS, las mismas que no deben afectar la atención a los pacientes.

l) Ante la declaratoria de un estado de emergencia nacional o de una emergencia sanitaria en el país, o debido a la crisis sanitaria generada por una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, se establece el sistema de atención escalonada o piramidal, a fin de atender a los pacientes en los eventos precitados, considerando lo señalado en el Anexo N° 18.

6.6.1 REQUISITOS MÍNIMOS DEL RECURSO HUMANO DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

Los requisitos mínimos del recurso humano de la UPSS Cuidados Intensivos son:

a) Médico cirujano de la UPSS Cuidados Intensivos:

- Título Profesional Universitario de Médico Cirujano.
- Título de Especialista en Medicina Intensiva.
- Registro Nacional de Especialista en Medicina Intensiva.
- Capacitación BLS y/o ACLS según corresponda.
- En el caso de las unidades de cuidados intensivos de especialidades, los médicos son de la especialidad a la que está dedicada dicha unidad.

b) Profesional en Enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos.

- Título Profesional Universitario en Enfermería.
- Título de Segunda especialización de Enfermería en Cuidados Intensivos.
- Registro Nacional de Especialista.
- Capacitación BLS o ACLS según corresponda.

c) Personal Técnico (a) en Enfermería

- Título Técnico de Instituto Superior de 6 semestres académicos: Enfermería Técnica.
- Experiencia mínima de 2 años en la UPSS Hospitalización o en la UPSS Emergencia.

6.6.2 RESPONSABILIDADES DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

6.6.2.1 Del médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos:

a) Desarrolla e implementa los documentos de organización y funcionamiento de la UPSS Cuidados Intensivos dispuestos en la presente norma.

b) Administra la UPSS como una unidad de gestión, así como, planifica el presupuesto que asegure la dotación suficiente y oportuna de los

insumos y equipos necesarios para garantizar la seguridad de las prestaciones y la bioseguridad del personal.

c) Gestiona el sistema de información y registro de la información estadística y epidemiológica de la UPSS Cuidados Intensivos, y analiza los indicadores de gestión clínica y evaluación de la calidad, generando las propuestas de mejora, en coordinación con la Oficina de Gestión de la Calidad del establecimiento de salud, o de la que haga sus veces. Esta oficina realizará el posterior monitoreo y evaluación de la implementación del Plan de Mejora.

d) Supervisa la actualización del inventario de equipamiento biomédico, así como el mantenimiento correctivo y preventivo del mismo, a cargo del equipo de ingeniería o ingeniería biomédica, y propone al responsable del establecimiento de salud, el reemplazo de equipos en el plan de reposición de equipos del establecimiento de salud.

e) Promueve la investigación clínica, la investigación operativa y la docencia.

f) Promueve el desarrollo de habilidades comunicativas de todo el personal de la UPSS Cuidados Intensivos y la empatía a tener, con el paciente y su familiar, o representante.

g) Vela por los aspectos éticos y sociales relacionados con la medicina intensiva, en coordinación con la oficina de calidad del establecimiento de salud o de la que haga sus veces.

h) Elabora la programación de turnos de trabajo o de guardias del personal médico.

i) Promueve y gestiona la elaboración de protocolos y guías de práctica clínica.

j) Promueve y gestiona los planes de contingencia correspondientes diferentes a los planes de emergencias y desastres.

k) Promueve e implementa el Plan de Gestión de Riesgos de la UPSS Cuidados Intensivos.

l) Promueve la cultura de seguridad de la atención del paciente, así como el registro y reporte de eventos adversos.

m) Colabora con la dirección, o gerencia, del establecimiento de salud en las decisiones de planificación y cobertura del personal y sustenta el requerimiento de recursos humanos para la UPSS Cuidados Intensivos.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

6.6.2.2 Del Médico cirujano especialista en medicina intensiva:

a) Actúa bajo los principios de integridad y ética profesional en todo momento o circunstancia de su actividad profesional.

b) Conduce y lidera la visita médica interdisciplinaria, así como, elabora y cumple el plan de trabajo para cada paciente.

c) Supervisa el registro en la historia clínica del paciente, manual o electrónica, el llenado del puntaje (score) de gravedad del paciente.

d) Realiza el registro en la historia clínica del paciente, manual o electrónica, de los procedimientos médicos efectuados en su turno, o guardia.

e) Brinda el informe médico diario de cada paciente, a su familiar y/o representante, con claridad y empatía.

f) Solicita el consentimiento informado y deja constancia de ello, consignando la firma del paciente, si éste pudiera realizarla, o de su familiar o representante legal.

g) Informa al médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, las ocurrencias o incidencias que acontecen en su turno, o guardia, las cuales son registradas en el registro de incidencias u ocurrencias, por medio manual o electrónico. Estas ocurrencias e incidencias están sujetas a procesos de mejora en la UPSS Cuidados Intensivos.

h) Identifica y reporta los incidentes y eventos adversos relacionados a la seguridad del paciente, y participa en la implementación de prácticas seguras en la atención del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos.

i) Cumple con el llenado de las listas de verificación de los procedimientos médicos que se realizan en la UPSS Cuidados Intensivos.

j) Responde las interconsultas de las diferentes UPSS del establecimiento de salud dirigidas a la UPSS Cuidados Intensivos.

k) El médico cirujano especialista en medicina intensiva de los Cuidados Intensivos Extendidos CIE, acude a la respuesta de las interconsultas de las diferentes UPSS del establecimiento de salud y monitorea estrechamente al paciente hasta que se remita su estado crítico, o se considere el manejo paliativo; coordina con la UPSS Cuidados Intensivos si existe la necesidad de ingreso y si se dispone de cama.

l) El médico cirujano especialista en medicina intensiva corrobora la operatividad de los equipos, que ha sido verificada antes y durante cada turno, por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos.

m) Participa en las reuniones de gestión, capacitación y en las juntas médicas, cuando es convocado por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.

n) Otras responsabilidades encargadas por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, dentro del marco de sus competencias.

C. ALVARADO CH.

6.6.2.3 Del Médico cirujano especialista en medicina interna, cardiología, anestesiología, neumología, medicina de emergencias y desastres, capacitado en cuidados intensivos.

a) Complementa el trabajo del médico cirujano especialista en medicina intensiva.

b) Actúa bajo los principios de integridad y ética en todo momento o circunstancia de su actividad profesional.

c) Cumple el plan de trabajo para cada paciente.

d) Cumple con la normatividad vigente con relación a la Vigilancia Epidemiológica, con el correspondiente registro y firma de los formatos que correspondan.

e) Efectúa el registro en la historia clínica, manual o electrónica, así como el llenado del puntaje (score) de gravedad del paciente.

f) Efectúa el registro de los procedimientos médicos efectuados en su turno o guardia, en forma electrónica o manual, en función al equipamiento disponible.

g) Brinda el informe médico de cada paciente al familiar o representante; para ello desarrolla habilidades comunicativas y de empatía.

h) Solicita el consentimiento informado y deja constancia de ello, consignando la firma del paciente, si este pudiera realizarla, o de su familiar o representante.

i) Informa al médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o de guardia, y al médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, las ocurrencias o incidencias, las cuales son registradas mediante vía manual o electrónica. Estas ocurrencias e incidencias están sujetas a procesos de mejora en la UPSS Cuidados Intensivos.

j) Identifica y reporta los incidentes y eventos adversos relacionados a la seguridad del paciente y participa en la implementación de prácticas seguras en la atención del paciente.

k) Cumple con el llenado de las listas de verificación de los procedimientos médicos que se realizan en la UPSS Cuidados Intensivos.

l) Responde las interconsultas de las diferentes UPSS del establecimiento de salud dirigidas a la UPSS Cuidados Intensivos.

m) Acude a la respuesta de interconsultas de las diferentes UPSS del establecimiento de salud y monitorea estrechamente al paciente hasta que se remita el estado crítico, o se considere el manejo paliativo; coordina con la UPSS Cuidados Intensivos si existe la necesidad de ingreso y/o la disponibilidad de cama.

n) Corrobora la operatividad de los equipos, que ha sido verificada antes y durante cada turno, por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos.

o) Participa en las reuniones de gestión, capacitación, y en las juntas médicas cuando es convocado por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.

p) Se capacita en la atención médica en cuidados intensivos, según el plan de capacitación de la UPSS y es evaluado continuamente por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.

q) Cumple obligatoriamente con los requisitos y competencias para el trabajo en la UPSS Cuidados Intensivos.

r) Otras responsabilidades encargadas por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS o por el médico cirujano especialista en Medicina Intensiva de turno o guardia.

6.6.2.4 Del profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería en la UPSS Cuidados Intensivos

a) Cumple los roles de dirección, planificación y supervisión del personal en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos; así como, realiza el seguimiento de los objetivos y de la evaluación de los resultados de las actividades de enfermería.

b) Organiza y garantiza los cuidados de enfermería para cada paciente.

c) Promueve la capacitación continua en cuidados intensivos del personal en enfermería.

d) Promueve la capacitación continua del personal técnico (a) en enfermería en el apoyo a los cuidados del paciente.

e) Promueve el estudio de casos y la investigación de enfermería en cuidados intensivos.

f) Participa en la discusión y realización de protocolos y guías de práctica clínica y asegura su cumplimiento.

g) Elabora con el equipo de profesionales en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos, guías técnicas, manuales de procedimientos y planes de intervenciones de enfermería en cuidados intensivos.

h) Implementa las prácticas seguras en la atención de pacientes, evalúa la calidad de los cuidados y realiza el seguimiento de los incidentes críticos.

i) Colabora con la gestión de ingresos y salidas de la UPSS, y traslados de pacientes.

j) Asegura que el paciente, su familiar, o representante legal, tengan la información que requieren sobre los cuidados de enfermería; para ello desarrolla habilidades comunicativas y empatía.

k) Colabora con el departamento o servicio de enfermería del establecimiento de salud en: decisiones de planificación y cobertura del personal, requerimientos de los recursos de la UPSS Cuidados Intensivos, evaluación del personal en enfermería, programación de la capacitación continua de los profesionales en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

6.6.2.5 Del profesional de enfermería especialista en cuidados intensivos.

a) Brinda los cuidados continuos de enfermería y comunica oportunamente al médico cirujano especialista en medicina intensiva los hallazgos encontrados y las alteraciones presentadas en el paciente.

b) Administra los medicamentos, según lo prescrito por el médico cirujano especialista en medicina intensiva, poniendo especial cuidado en los Medicamentos de Alto Riesgo (MAR).

c) Brinda los cuidados integrales al paciente y familia, y realiza los procedimientos requeridos de acuerdo al proceso de atención de enfermería (PAE) siendo responsable de los mismos.

d) Cumple con la normatividad vigente con relación a la Vigilancia Epidemiológica, con el correspondiente registro y firma de los formatos que correspondan.

e) Cumple con las prácticas integrales de seguridad en la atención del paciente.

f) Organiza y registra el stock de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la UPSS Cuidados Intensivos.

g) Coordina con el químico farmacéutico, o quien haga sus veces, la dosis unitaria, la disponibilidad y reposición de los insumos y medicamentos listados para el coche de paro y el stock de medicamentos de la UPSS Cuidados Intensivos.

h) Es responsable de verificar la operatividad de los equipos de soporte vital inmediato al inicio de cada turno, y durante éste; reporta los problemas que pudieran existir al profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería y éste al personal de servicios generales y pone en conocimiento al médico

cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.

i) Informa y coordina con el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia, el equipamiento que es necesario en el turno o el faltante.

j) Participa en la realización de procedimientos, asistiendo al médico cirujano especialista en medicina intensiva y monitoreando al paciente durante todo el procedimiento, según su competencia.

k) Supervisa la limpieza, desinfección y cuidado de los equipos biomédicos.

l) Realiza los registros de enfermería en la hoja de monitoreo de enfermería.

m) Asegura que el paciente, el familiar y/o el representante legal, tengan la información que requieran sobre los cuidados de enfermería; para ello desarrolla habilidades comunicacionales y empatía.

n) Coordina, con el personal de los servicios de apoyo al diagnóstico y al tratamiento, el traslado y la seguridad del paciente durante la realización de exámenes y procedimientos fuera de la UPSS Cuidados Intensivos.

o) Es responsable de la custodia y el cuidado de la historia clínica, de los exámenes auxiliares y de las imágenes.

p) Cumple con el llenado de scores en enfermería (NAS, NEMS o TISS) y las listas de verificación de procesos de enfermería en cada turno.

q) Resguarda la historia clínica manuscrita y la mantiene en orden.

r) Cumple las listas de verificación que le son asignadas.

s) Participa en la visita médica como parte del equipo interdisciplinario.

t) Participa en las reuniones de gestión convocadas por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería.

u) Coordina con la Unidad de Terapia Respiratoria y Bioingeniería Médica o Tecnología Aplicada los reportes relacionados con la operatividad de las máquinas de soporte vital.

v) Supervisa al personal técnico (a) en enfermería.

w) Se capacita en cuidados intensivos, según el Plan de capacitación de la UPSS Cuidados Intensivos.

x) Otras responsabilidades encargadas por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería, y por el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos, y del médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia, dentro del marco de sus competencias.

6.6.2.6 Del profesional en enfermería capacitado en cuidados intensivos.

a) Complementa el trabajo del profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos.

b) Brinda los cuidados continuos de enfermería y comunica oportunamente al médico cirujano especialista en medicina intensiva los hallazgos encontrados y las alteraciones presentadas en el paciente.

c) Administra los medicamentos según lo prescrito por el médico cirujano especialista en medicina intensiva.

d) Brinda los cuidados integrales de enfermería al paciente y familia, y realiza los procedimientos de acuerdo al proceso de atención de enfermería (PAE) siendo responsable de los mismos.

e) Cumple con la normatividad vigente con relación correspondiente a la Vigilancia Epidemiológica, con el correspondiente registro y firma de los formatos que correspondan.

f) Cumple con las prácticas de seguridad en la atención del paciente.

g) Organiza y registra el stock de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios de la UPSS Cuidados Intensivos.

h) Coordina con el químico farmacéutico, o quien haga las veces, la dosis unitaria, la disponibilidad y reposición de los insumos y medicamentos listados para el coche de paro y el stock de medicamentos de la UPSS.

i) Es responsable de verificar la operatividad de los equipos de soporte vital inmediato, al inicio de cada turno y durante éste; reporta los problemas que pudieran existir al profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería y éste al personal de servicios generales y pone en conocimiento al médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.

j) Apoya a los médicos cirujanos especialistas en medicina intensiva en la realización de los procedimientos médicos, según su competencia.

MINISTERIO DE SALUD Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

k) Supervisa la limpieza, desinfección y cuidado de los equipos biomédicos.

l) Realiza los registros de enfermería en la hoja de monitoreo de enfermería.

m) Asegura que el paciente, el familiar y/o el representante tengan la información que requieran sobre los cuidados de enfermería; para ello desarrolla habilidades comunicacionales y empatía.

n) Coordina con el personal de los servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, el traslado y la seguridad del paciente durante la realización de exámenes y procedimientos médicos, fuera de la UPSS Cuidados Intensivos.

o) Es responsable de la custodia y el cuidado de la historia clínica, de los exámenes auxiliares y de las imágenes.

p) Cumple con el llenado de scores en enfermería (NAS, NEMS o TISS) y las listas de verificación de procesos de enfermería en cada turno.

q) Participa en la visita médica como parte del equipo interdisciplinario.

r) Resguarda la historia clínica manuscrita y la mantiene en orden.

s) Cumple las listas de verificación que le sean asignadas.

t) Participa en las reuniones de gestión convocadas por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, responsable de enfermería.

u) Coordina con la Unidad de Terapia Respiratoria y Bioingeniería Médica o Tecnología Aplicada los reportes relacionados con la operatividad de las máquinas de soporte vital.

v) Se capacita en cuidados intensivos según el Plan de capacitación de la UPSS Cuidados Intensivos.

w) Cumple con los requisitos y las competencias para el trabajo en la UPSS Cuidados Intensivos.

x) Apoya al profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos en los procedimientos y en el cuidado del paciente en estado crítico, según las guías técnicas de procedimiento e intervenciones.

y) Otras responsabilidades encargadas por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería en la UPSS Cuidados Intensivos.

6.6.2.7 Del Personal Técnico (a) en Enfermería

Bajo la estricta supervisión del profesional en enfermería:

a) Apoya a realizar las actividades vinculadas al ordenamiento, control, distribución y mantenimiento, de ambientes, suministros, equipos, insumos y materiales.

b) Apoya a realizar las actividades vinculadas a la gestión del abastecimiento de medicamentos, materiales o insumos para la atención del paciente, así como citas para los procedimientos médicos requeridos por los pacientes.

c) Realiza las actividades vinculadas al registro de datos relacionados a su labor, utilizando los formatos y medios respectivos.

d) Realiza la limpieza y desinfección de la cama y de la unidad del paciente, según norma establecida.

e) Realiza el apoyo en la asistencia al paciente según la indicación del profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos; para ello desarrolla empatía y procede con delicadeza y cuidado.

f) Otras responsabilidades encargadas por el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos y por el médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos, dentro del marco de sus competencias.

C. ALVARADO CH.

6.6.2. CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS.

a) El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería, realizan el requerimiento de las necesidades de capacitación, según lo programado en el Plan de Desarrollo de Personal - PDP institucional o en el documento que haga sus veces en el establecimiento de salud, así como las estrategias de educación continua.

b) En el PDP institucional o en el documento que haga sus veces, se incluye el Plan Anual de Capacitación y el Plan Anual de Docencia; y en el caso de Institutos de Salud Especializados se incluye el Plan Anual de Docencia e Investigación.

c) En el PDP institucional o en el documento que haga sus veces, se incluyen capacitaciones en: integridad, ética, bioética, bioseguridad, seguridad del paciente entre otros.

d) En la UPSS Cuidados Intensivos se sostienen conversatorios clínico patológicos en forma periódica con la participación de los profesionales de la salud involucrados en el proceso de atención de salud de los pacientes.

6.6.2.1 Capacitación del médico cirujano especialista en medicina intensiva, médico cirujano pediatra especialista en medicina intensiva pediátrica,

médico cirujano pediatra con subespecialidad en neonatología y médico cirujano de la especialidad de neonatología (y del médico cirujano de las especialidades de Medicina en Emergencias y Desastres, Anestesiología, Medicina interna, Cardiología y Neumología, capacitados y certificados en cuidados intensivos, capacitado en cuidados intensivos en los casos que contempla el numeral 6.2.10).

En el Plan de capacitación de la UPSS Cuidados Intensivos precede lo siguiente:

Precedencia 1

a) Soporte cardiovascular de vida avanzado.
b) Soporte oxigenatorio, ECMO.
c) Ventilación Mecánica avanzada invasiva y no invasiva.
d) Sistema de alto flujo.
e) Cuidados Intensivos Neurocríticos.
f) Muerte Encefálica.
g) Sostenimiento del Donante de Órganos.
h) Manejo del Paciente Postrasplantado en estado Crítico.
i) Fundamentos en el Soporte de Cuidado Crítico (FCCS).
j) Fundamentos en el Soporte del paciente crítico quirúrgico.
k) Fundamentos en manejo de desastres y emergencias masivas.
l) Curso de revisión de Medicina Intensiva Avanzada.
m) Procedimientos médicos en Medicina Intensiva: ultrasonido, traqueostomía percutánea, fibrobroncoscopía y otros procedimientos médicos invasivos.
n) Seguridad del paciente.
o) Ética y Humanización.
p) Comunicación asertiva en situaciones críticas.
q) Otras según perfil epidemiológico.

C. ALVARADO CH.

Precedencia 2

r) Gestión clínica en Cuidados Intensivos.
s) Uso de las tecnologías de la información y comunicación en medicina intensiva.
t) Terapia Nutricional Parenteral.

Precedencia 3

u) Bioingeniería aplicada a la medicina intensiva.
v) Terapia Nutricional Enteral especializada.

6.6.2.2 Capacitación del profesional en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos:

En el plan de capacitación del profesional en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos precede lo siguiente:

- Cursos relacionados a cuidados intensivos en enfermería.
  a) Admisión de pacientes en IRA en áreas críticas.
  b) Valoración de la función respiratorias.
  c) Exámenes diagnósticos e interpretación.
  d) Revisión de la fisiología respiratoria.
  e) Insuficiencia respiratoria aguda (IRA) en pacientes con síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA).
  f) Manejo terapéutico de la IRA y el SDRA pronación.
  g) Cuidados en el sistema de oxigenoterapia de bajo flujo.
  h) Cuidados en el sistema de oxigenoterapia de alto flujo.
  i) Manejo de ansiedad y dolor en oxigenoterapia de alto flujo.

j) Principios básicos de ventilación mecánica, programación inicial, indicaciones y modos ventilatorios.
k) Monitoreo del paciente con soporte ventilatorio invasivo y no invasivo
l) Monitoreo de alarmas, ondas y bucles.
m) Cuidados en sedación e inicio de destete ventilatorio, soporte psicoemocional.
n) Limpieza, desinfección y armado de ventilador mecánico.
o) Ventilación mecánica no invasiva.
p) Monitoreo hemodinámico
q) Titulación y preparación de drogas inotrópicas/vasoactivas y fluidoterapia en estado de shock
r) Asistencia mecánica: Cuidados en el monitoreo del Balón de contrapulsación aórtica
s) Seguridad del paciente.
t) Actualización de Cuidados de paciente según perfil epidemiológico

- Uso de las tecnologías de la información y comunicación en medicina intensiva.

6.7 INFRAESTRUCTURA

6.7.1 UBICACIÓN

La UPSS Cuidados Intensivos se ubica en un lugar aislado acústicamente y con vías de acceso restringidas, con acceso directo por ascensor o pasadizos liberados hacia la UPSS Emergencia, Centro Quirúrgico, Laboratorio e Imágenes y otros de necesidad para una oportuna atención del paciente en estado crítico, como la UPSS de Quemados.

C. ALVARADO CH.

6.7.2 ZONIFICACIÓN DE AMBIENTES EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

Se zonificarán las áreas de trabajo de la siguiente forma:

Zona Negra (Administrativa)	Recepción y Control del Ingreso de visita. Sala de espera y Ambiente para informe al familiar, y/o al representante, del paciente. Oficina para el médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y área administrativa. Oficina para profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería. Sala de reuniones. Cuarto técnico.
Zona Gris (Apoyo al personal)	Almacén de ropa estéril. Área de equipamiento biomédico: ventiladores mecánicos, monitores de funciones vitales, fibrobroncoscopio, entre otros, con sus materiales e insumos correspondientes. Servicios higiénicos y vestidores diferenciados para el personal. Sala de descanso del personal que incluye baño. Sala de ropa limpia.

	Ambiente de trabajo sucio. Ambiente de trabajo limpio. Ambiente de ropa sucia. Cuarto de Limpieza. Almacén intermedio de residuos sólidos. Almacén para Equipo de radiografía rodable, Equipo de ultrasonido, ecocardiografía, entre otros. Cuarto Séptico. Baños para el personal de salud en cantidad proporcional al número de recursos humanos programados por turno. Ambiente de desinfección de incubadoras y cambios de filtros. Lactario para la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.
Zona Blanca	Área de recepción del paciente. Ambiente exclusivo para preparado de dieta o almacenamiento de nutrición enteral total NET o nutrición parenteral NPT.
	Estación de enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos. Almacén de equipos e instrumental. Almacén de medicamentos, insumos y materiales estériles.
Zona de pacientes	Esclusa Mínimo de 20 m^2 por cama. Ambiente para paciente en aislamiento mínimo de 24 m^2 incluido esclusa.

C. ALVARADO CH.

a) La zona de pacientes tiene un diseño modular abierto con visión directa desde una zona central; cada módulo considera un máximo de 06 camas que incluyen un cubículo con exclusa para aislamiento de pacientes. Área por cama: 16 m2 y ampliable a 20 m2 y en caso de aislamiento y por aumento de los equipos ampliable a 24 m2.

b) El espacio de la esclusa debe disponer de un mínimo de 6 metros cuadrados para ubicar lavado de manos, preparación y almacenaje, posibilitando el paso de la cama.

c) La habitación de aislamiento dispone de una antesala que sirve como esclusa para la preparación del personal (lavado de manos y protecciones).

d) La ventilación es mecánica, de manera que garantice la renovación del aire

6.7.3 LA INGENIERÍA HOSPITALARIA Y EL DISEÑO

Los ambientes de la UPSS Cuidados Intensivos deben cumplir con las normas de infraestructura y equipamiento vigentes de los establecimientos de salud de II y III nivel de atención de salud que emite el Ministerio de Salud.

6.7.3.1 DISEÑO ARQUITECTÓNICO

a) Puertas con sistema de acceso restringido o intercomunicador con capacidad de apertura desde el interior.

b) Puertas de acceso amplias que permitan tránsito de camas y equipos de Radiología.

c) El mobiliario fijo anclado a piso o pared para seguridad en caso de sismo.

d) La disposición del equipamiento y mobiliario tiene en cuenta las características ergonómicas del personal de salud; y de la madre/padre en caso de unidad de cuidados intensivos neonatales.

e) La separación mínima entre camas es 2.5 m. En la unidad de neonatología la separación de camas es de 3.5m a fin de acceder para la atención al neonato por 3 lados.

f) Box de aislamiento con presión negativa, especialmente ante riesgo biológico o en pacientes inmunosuprimidos, en 30 % en la categoría III - 2 y 20% en categoría III - 1. La presión del Box de aislamiento debe ser dual: negativa y positiva (con comando mecánico) de acuerdo a la necesidad funcional del paciente en estado crítico (pacientes inmunosuprimidos o altamente infecciosos).

g) Enchufe triple "tipo B" (para equipos biomédicos; bombas, ventiladores, monitores, etc.). Las tomas corrientes deben ser dobles estabilizadas.

6.7.3.2 ACABADOS.

a) Los cubículos de los pacientes están separados entre sí por tabiquería de aluminio con vidrio templado mínimo de 8 mm y pavonado hasta 1.5 m del piso.

b) Los lavaderos disponen de un mandil de 60 cm sobre el mueble fijo.

c) Grifería con cuello de ganso accionado con pedal o infrarrojo.

d) Cielo raso y falso cielo raso antifúngico y antibacterial.

e) Contra zócalo sanitario con altura mínima de 10 cm.

f) Pisos antideslizantes de alto tránsito y de fácil limpieza.

g) Muros revestidos de material de fácil limpieza, sin juntas sobre el contra zócalo sanitario.

C. ALVARADO CH.

6.7.3.3 DISEÑO ESTRUCTURAL

a) Considera la Norma E. 030 del Reglamento Nacional de Edificaciones aprobada por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, o la que haga sus veces.

b) Considera incluir un espacio para brindar el servicio de Teleinterconsulta, donde se coloque el equipamiento básico que permita realizar la transmisión.

6.7.3.4 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS.

a) Toma mural horizontal a cada lado de la cama con rieles para soportar monitores, que tenga un diseño ergonómico y de fácil limpieza.

b) Toma mural para UPSS Cuidados Intensivos de categoría II-2 y Estativas con dos brazos articulados para categoría III.

c) Cada toma mural dispone de:

   i. Doce (12) tomacorrientes tipo shucko controlado por interruptor dedicado.

   ii. Sistema de toma empotrado de oxígeno, con material y colores según norma ISO.

iii. Sistema de toma de aire comprimido, con material y colores según norma ISO.

iv. Sistema de vacío.

v. Dos (02) salidas para data conectado a central de enfermería.

vi. 1 rack para fijar monitor.

vii. Sistema de energía eléctrica continua e ininterrumpida (sistema de UPS) con mínimo de treinta (30) minutos.

viii. Enchufes de alto amperaje (2 por cama) para equipos especiales (Radiodiagnóstico, Ultrasonido para el paciente crítico).

d) Sistema de iluminación natural y de intensidad gradual con capacidad de iluminación independiente para cada cubículo. La disposición de la mayoría de las ventanas es fija con vidrio templado y pavonado con algunas ventanas con sistema hermético para disposición en casos de falla aire de acondicionado.

e) Los circuitos eléctricos están protegidos con interruptores diferenciales.

f) Tableros eléctricos cuentan con señalización de peligro eléctrico.

g) Cuarto técnico con sistema de ventilación natural adecuada para la UPSS, baterías, transformador y tablero de control.

h) Sistema de aire acondicionado 100% aire exterior limpio con filtro de alta eficiencia 99.97%, el cual es un sistema de inyección y extracción: en los ambientes que no tienen presión negativa el recambio mínimo de flujo laminar de 12 a 15 por hora, y en los de presión negativa las tasas de recambio de flujo serán entre 6 y 12 por hora.



i) Las unidades de cuidados intensivos tienen un sistema de presión positiva excepto del cubículo del paciente aislado que debe tener presión negativa.

j) El ambiente debe conservar una temperatura interior de mínimo 20 y 25 °C tendiendo al confort del paciente. En la Unidad de cuidados intensivos neonatales la temperatura ambiental debe estar en un rango de 22° y 25° C y una humedad relativa del 30-60%.

k) En las unidades de cuidados intensivos de especialidades se recomienda la climatización de cada habitación en forma individual.

l) Sistema de detectores de humo con panel central.

m) Material antimicrobiano en el exterior de las placas de interruptores, tomacorrientes, teléfonos y otros.

n) Grupo electrógeno y equipo de luz auxiliar.

6.7.3.5 INSTALACIONES SANITARIAS

a) Baño para paciente con doble descarga y flujómetro.

b) Contar con un lavamanos cada 3 camas que debe ser eléctrico o a pedal.

c) En caso de unidad de cuidados intensivos neonatales se recomienda lavatorios de 61 cm de ancho, 41 cm de fondo y 25 cm de profundidad.

d) Demás instalaciones según normatividad vigente en cuanto a infraestructura y equipamiento.